



Nuansa
Fajar
Cemerlang

KELUARGA BERENCANA

UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI
PERENCANAAN KELUARGA MASA PRA KONSEPSI

Inggar Ratna Kusuma • Musafaah
Purwati



KELUARGA BERENCANA: UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PERENCANAAN KELUARGA MASA PRA KONSEPSI

Dr. Inggar Ratna Kusuma, S.ST., MPH.

Dr. Musafaah, SKM., MKM.

Purwati, S.ST., MPH.



Keluarga Berencana: Upaya Pencegahan Stunting Melalui Perencanaan Keluarga Masa Pra Konsepsi

Penulis: Dr. Inggar Ratna Kusuma, S.ST., MPH.
Dr. Musafaah, SKM., MKM.
Purwati, S.ST., MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantionso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-30-6

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Keluarga berencana : upaya pencegahan stunting melalui perencanaan keluarga masa pra konsepsi / penulis, Dr. Inggar Ratna Kusuma, S.S.T., M.P.H., Dr. Musafaah, S.K.M., M.K.M., Purwati, S.S.T., M.P.H.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vii, 122 halaman : ilustrasi ; 30 cm
ISBN 978-634-7139-30-6
Keluarga berencana - Aspek kesehatan -- Konsepsi (Biologi) -- Kontrasepsi
363.96 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1186172>

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku monograf ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini berjudul "Keluarga Berencana: Upaya Pencegahan Stunting Melalui Perencanaan Keluarga Masa Pra Konsepsi" ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya perencanaan keluarga dalam mencegah stunting, sebuah isu kesehatan yang semakin menjadi perhatian di Indonesia.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif mereka. Dalam konteks ini, perencanaan keluarga menjadi salah satu strategi kunci untuk memastikan bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi yang optimal, baik dari segi kesehatan maupun gizi. Melalui pendekatan masa pra konsepsi, kita dapat mempersiapkan calon orang tua untuk memberikan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan anak mereka.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi bagi berbagai kalangan, termasuk tenaga kesehatan, pendidik, peneliti, dan masyarakat umum. Dengan mengintegrasikan pengetahuan tentang keluarga berencana dan pencegahan stunting, kami berharap pembaca dapat memahami betapa pentingnya perencanaan yang matang sebelum kehamilan.

Dalam buku ini, kami menyajikan berbagai aspek terkait keluarga berencana, mulai dari konsep dasar hingga praktik terbaik yang dapat diterapkan. Selain itu, kami juga menyertakan studi kasus dan data terkini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi stunting di Indonesia serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua individu dan institusi yang telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca dalam upaya bersama untuk mencegah stunting melalui perencanaan keluarga yang baik.

Selamat membaca!

(Desember, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 PENTINGNYA PERENCANAAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN STUNTING	5
A. Definisi dan tujuan Perencanaan Keluarga	5
B. Definisi Keluarga Berencana PascaPersalinan	7
C. Kebijakan Keluarga Berencana dan Kependudukan di Indonesia.....	8
D. Masa pra konsepsi.....	10
E. Keterkaitan KB dengan stunting	11

BAB 3 KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA BERENCANA.....	15
A. Peran KIE dalam Meningkatkan Kesadaran tentang KB.....	15
B. Metode Penyuluhan yang efektif.....	18
C. Peningkatan akses terhadap informasi.....	20

BAB 4 KONSELING KELUARGA BERENCANA	25
A. Definisi Konseling Keluarga Berencana	25
B. Prinsip-prinsip konseling Keluarga Berencana (Sulistyawati, 2019).....	26
C. Metode konseling Keluarga Berencana	28

D. Proses konseling	38
---------------------------	----

BAB 5 MACAM-MACAM METODE KONTRASEPSI

SEDERHANA.....41

A. Metode Amenore Laktasi.....	41
B. Suhu Basal Tubuh	43
C. Senggama terputus (Coitus interruptus/withdrawal).....	44
D. Sistem Kalender.....	45
E. Lendir Serviks	47
F. Metode Simptotermal.....	49

BAB 6 MACAM-MACAM KONTRASEPSI MODERN.....51

A. Kontrasepsi oral kombinasi.....	51
B. Pil Progestin.....	52
C. Suntik Progestin	53
D. Suntik Kombinasi	55
E. Intrauterine Device (IUD)	56
F. Implant.....	57
G. Sterilisasi Wanita	58
H. Sterilisasi Pria.....	59

BAB 7 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA STUNTING

DAN INTERVENSI YANG DILAKUKAN61

A. Definisi Stunting.....	61
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting secara mikro, meso dan makro.	61
C. Intervensi spesifik penanggulangan stunting.....	72
D. Intervensi sensitive penanggulangan stunting.....	74

BAB 8 KEBIJAKAN DAN PROGRAM KELUARGA	
BERENCANA DALAM PENCEGAHAN STUNTING	77
A. Keluarga Berencana dan Stunting.....	77
B. Kebijakan Program Bangsa Kencana dan Stunting di Indonesia.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	85
GLOSARIUM	119
PROFIL PENULIS	123

BAB 1

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan yang cukup serius dan menjadi sorotan pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2022 sebesar 21,6%, ada penurunan 2,8% dari tahun sebelumnya (SSGI, 2023). Diagnosis stunting ditegakkan berdasarkan tinggi badan per umur dengan nilai z score kurang dari -2.00 Standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3.00 standar deviasi (*severely stunted*) diikuti dengan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang (Permenkes, 2021). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan *stunting* adalah gangguan pertumbuhan yang tidak sesuai sehingga menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Penyebab stunting dari beberapa penelitian disebabkan karena berbagai faktor diantaranya pengetahuan orang tua, Pendidikan orang tua, pemberian ASI eksklusif, pola asuh dalam pemberian makan, pendapatan keluarga (Ekonomi keluarga), pekerjaan orang tua, Riwayat penyakit infeksi, Riwayat BBLR dan pelayanan kesehatan (Ni'mah&Nadhiroh,2015; Supariasah&Purwaningsih, 2019; Tebi dkk, 2021; Sairah dkk, 2023).

Upaya pencegahan stunting sebagai agenda Pembangunan sumber daya manusia dalam pencapaian Visi Indonesia emas 2045. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang harus dipenuhi untuk mewujudkan visi tersebut. Hambatan dari kualitas SDM ini salah satunya *stunting*, dimana stunting mempunyai dampak nyata dari segala sisi yaitu Kesehatan dan ekonomi baik jangka

pendek dan jangka Panjang. Kejadian stunting menyebabkan kecerdasan anak menjadi kurang, hal ini karena sel otak tidak berkembang secara optimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini tetapi akan berlanjut hingga usia dewasa. Jika stunting tidak tertangani maka kesehatan anak menurun, kecerdasan tidak optimal dan akan berdampak pada produktifitas SDM dan perekonomian baik individu maupun secara umum.

Pencegahan stunting dilakukan secara terpadu dan paripurna melibatkan muktisektoral dengan melakukan pendamping keluarga. Keluarga merupakan bagian utama dalam pencegahan stunting, sehingga Upaya pencegahan diawali dari keluarga. Upaya tersebut diantaranya pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan dalam keluarga, deteksi dini ibu hamil yang beresiko melahirkan bayi stunting serta mendampingi keluarga yang mempunyai balita hingga usia 5 tahun (BKKBN, 2021).

Salah satu Upaya pencegahan stunting melalui Keluarga Berencana (KB). Program KB bertujuan untuk merencanakan, mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu serta memberi kesempatan pada anak untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan menjadi generasi yang berkualitas sesuai dengan visi indonesia emas 2045. KB juga dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada usia muda atau usia tua yang meningkatkan kejadian stunting. Selain itu KB membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan mengatur jumlah anak sesuai dengan kemampuan perekonomian dan SDM yang ada. Hal ini memungkinkan keluarga memberikan perhatian dan pengasuhan yang lebih baik pada setiap anggotanya. Program KB harus didukung dengan akses terjangkau untuk alat kontrasepsi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, sedangkan pencegahan stunting

membutuhkan upaya Bersama dari berbagai pihak baik keluarga, Masyarakat dan pemerintah.

BAB 2

PENTINGNYA PERENCANAAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

A. Definisi dan tujuan Perencanaan Keluarga

Perencanaan keluarga merupakan aspek penting dari kesehatan reproduksi yang mencakup berbagai metode dan layanan yang bertujuan membantu individu dan pasangan mengatur jumlah dan waktu kelahiran anak-anak mereka. Proses ini meliputi penggunaan metode kontrasepsi, fertilitas, dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi.

Definisi Perencanaan Keluarga

Perencanaan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan individu dan pasangan untuk mengatur dan mencapai jumlah anak yang mereka inginkan serta waktu dan jarak kelahiran mereka. Hal ini dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan pengobatan infertilitas, Sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Stith Butler A, 2019). Upaya perencanaan keluarga tidak hanya tentang kontrasepsi tetapi juga pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pencegahan infeksi menular seksual (IMS), dan pengelolaan infertilitas (World Health Organization, 2022)

Tujuan Perencanaan Keluarga

Tujuan perencanaan keluarga memiliki banyak segi, dengan fokus pada kesehatan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama meliputi:

1. Mencegah Kehamilan yang Tidak Diinginkan

Perencanaan keluarga bertujuan untuk membantu pasangan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan negatif bagi ibu dan bayi.

2. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi

Memberi jarak kehamilan yang cukup (idealnya setidaknya dua tahun) mengurangi risiko yang terkait dengan morbiditas ibu dan mortalitas bayi. Hal ini memungkinkan ibu untuk pulih secara fisik dan emosional di antara kehamilan

3. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi

Memungkinkan keluarga untuk merencanakan kapan akan memiliki anak, perencanaan keluarga membantu mereka mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, yang berkontribusi pada stabilitas keuangan yang lebih baik.

4. Mempromosikan Kesenjangan Gender

Perencanaan keluarga memberdayakan perempuan dengan memberi mereka kendali atas pilihan reproduksi mereka, yang dapat mengarah pada partisipasi yang lebih besar dalam pendidikan dan angkatan kerja

5. Mengurangi Penyebaran IMS

Layanan perencanaan keluarga sering kali mencakup pendidikan tentang praktik seks yang aman, yang dapat membantu mengurangi kejadian infeksi menular seksual.

6. Mendukung Pembangunan Sosial

Akses terhadap keluarga berencana berkontribusi pada tujuan sosial yang lebih luas seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan hasil pendidikan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Definisi Keluarga Berencana PascaPersalinan

Pelayanan Keluarga Berencana PascaPersalinan merupakan pelayanan KB yang diberikan segera setelah ibu melahirkan hingga hari ke 42 postpartum (BKKBN, 2020).

Keluarga berencana pasca persalinan sangat penting untuk perencanaan keluarga karena (Indrawati and Ulfiana, 2022):

Kesehatan Ibu dan Anak: Mengatur jarak kelahiran yang sehat memungkinkan ibu untuk pulih sepenuhnya dari proses persalinan sebelum hamil lagi. Jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu, seperti komplikasi kehamilan, serta bagi anak, seperti kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah.

1. Menjaga Kesehatan Mental: Memberi jarak antar anak dapat membantu ibu untuk lebih siap secara mental dan fisik dalam mengurus anak-anak yang lebih banyak. Mengelola stres dan beban emosional dengan waktu yang cukup di antara kelahiran sangat penting.
2. Kesejahteraan Ekonomi: Dengan mengatur jumlah anak sesuai kemampuan finansial, keluarga bisa lebih mudah merencanakan pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga.
3. Pemberdayaan Wanita: Keluarga berencana memberi perempuan kontrol lebih besar atas keputusan reproduksi mereka, memungkinkan mereka untuk merencanakan karier, pendidikan, dan kehidupan pribadi dengan lebih baik.
4. Mencegah Kehamilan yang Tidak Direncanakan: Penggunaan alat kontrasepsi atau metode keluarga berencana setelah melahirkan dapat mengurangi risiko

kehamilan yang tidak diinginkan, yang bisa memengaruhi kualitas hidup ibu dan anak.

C. Kebijakan Keluarga Berencana dan Kependudukan di Indonesia

1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan Dan Pasca Keguguran. (BKKBN, 2017)

Dalam pelayanan KBPP bidan memberikan konseling dan pelayanan KBPP

- a. BAB I Pasal 19 konseling adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif tentang KB, dilakukan antara calon peserta KB dan petugas untuk membantu calon peserta KB mengenali kebutuhan ber-KBnya serta memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pemberian konseling KB PP dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan KIP/K. Konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan menggunakan alat bantu konseling, misalkan dengan media lembar balik, kartu konseling berimbang, leaflet atau poster
- b. BAB I Pasal 21 Konseling KB PP dan PK dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dan kegiatan yang berbasis masyarakat. Kegiatan konseling KB PP dan PK yang dilakukan di fasilitas kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pemeriksaan kehamilan (*Ante Natal Care*), kelas ibu hamil, kegiatan terpadu lainnya (P4K), sesaat setelah bersalin di ruang bersalin, kunjungan PNC, atau kelas ibu menyusui. Kegiatan konseling KB PP dan PK yang dilakukan di masyarakat

dapat terintegrasi dengan kegiatan posyandu ataupun kelompok kegiatan lainnya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Kementrian Kesehatan RI, 2023)
Bagian Ketujuh Kesehatan Keluarga Berencana Pasal 63 (1) Upaya Kesehatan keluarga berencana ditujukan untuk mengatur kehamilan, membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Upaya kesehatan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia subur. (3) Setiap orang berhak memperoleh akses ke pelayanan keluarga berencana. pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (5) Pelayanan Keluarga Berencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual
 - a. BAB I ketentuan umum pasal 1 pelayanan kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan.
 - b. BAB III pelayanan kontrasepsi pasal 24 kegiatan prapelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian komunikasi, informasi dan edukasi; b. pelayanan konseling; c.

penapisan kelayakan medis; dan d. permintaan persetujuan tindakan tenaga kesehatan. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada klien mengenai pilihan kontrasepsi berdasarkan tujuan reproduksinya

D. Masa pra konsepsi

Periode prakonsepsi meliputi waktu sebelum kehamilan terjadi, merupakan sangat penting bagi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Fase ini secara signifikan memengaruhi hasil kehamilan dan kesehatan jangka panjang ibu dan anak.

Pentingnya Periode Prakonsepsi (Stephenson, 2018)

1. Optimalisasi Kesehatan

Status kesehatan wanita prakonsepsi terkait langsung dengan keberhasilan kehamilannya dan kesehatan bayinya. Wanita yang sehat sebelum hamil lebih mungkin mengalami kehamilan yang sukses dan melahirkan anak yang sehat. Ini termasuk mengelola kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes atau hipertensi, yang dapat berdampak buruk pada kehamilan jika tidak dikontrol.

2. Kesiapan Gizi yang tepat sebelum konsepsi sangat penting.

Wanita dianjurkan untuk menerapkan pola makan seimbang yang kaya akan nutrisi penting, khususnya asam folat, yang membantu mencegah cacat tabung saraf pada janin yang sedang berkembang. Kekurangan gizi dapat menyebabkan komplikasi seperti berat badan lahir rendah dan masalah perkembangan.

3. Persiapan untuk hidup sehat

Periode prakonsepsi adalah waktu yang ideal bagi individu untuk membuat perubahan gaya hidup yang berdampak positif pada kesehatan reproduksi. Ini termasuk berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan menjaga berat badan yang sehat, yang semuanya dapat meningkatkan kesuburan dan memperbaiki hasil kehamilan.

4. Pendidikan dan Kesadaran

Perawatan prakonsepsi sering kali melibatkan pendidikan tentang risiko kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan kehamilan. Pasangan didorong untuk mendiskusikan perencanaan keluarga dengan penyedia layanan kesehatan, yang dapat mengarah pada persiapan yang lebih baik untuk menjadi orang tua.

5. Meminimalkan resiko unwanted pregnancy

Terlibat dalam perawatan prakonsepsi telah dikaitkan dengan penurunan hasil kehamilan yang merugikan seperti aborsi spontan, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Dengan mengatasi faktor risiko sebelum konsepsi, pasangan dapat secara signifikan meningkatkan peluang mereka untuk kehamilan yang sehat.

E. Keterkaitan KB dengan stunting

Kondisi ibu hamil dengan 4 T (terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) dapat beresiko terhadap kejadian stunting. Jarak kehamilan yang tidak ideal dapat memicu lahirnya bayi BBLR dan komplikasi yang lain.

Hubungan antara perencanaan keluarga dan stunting sangat penting dan beragam, khususnya di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keluarga yang efektif dapat menghasilkan hasil kesehatan anak yang lebih baik, termasuk penurunan angka stunting.

Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih baik pada anak-anak dan kejadian stunting yang lebih rendah. Misalnya, sebuah penelitian di Guatemala menemukan bahwa pengukuran langsung perencanaan keluarga, seperti penggunaan kontrasepsi modern, berkorelasi dengan peningkatan grafik pertumbuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika keluarga dapat secara efektif mengatur waktu dan jarak kehamilan, anak-anak lebih mungkin mencapai tonggak pertumbuhan yang sehat (Flood *et al.*, 2019).

Waktu antara kelahiran memainkan peran penting dalam gizi anak. Penelitian menunjukkan bahwa interval kelahiran yang lebih pendek (kurang dari 24 bulan) secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting. Misalnya, anak-anak yang lahir dalam rentang waktu 24 bulan dari saudara kandung yang lebih tua memiliki kemungkinan 52% lebih tinggi untuk mengalami stunting dibandingkan dengan mereka yang lahir setelah rentang waktu yang lebih lama. Hal ini menyoroti pentingnya keluarga berencana dalam memastikan sumber daya dan perawatan yang memadai untuk setiap anak.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Sulawesi Tengah, Indonesia, menunjukkan bahwa perilaku keluarga berencana secara langsung memengaruhi tingkat stunting di antara pasangan yang menikah dini. Penelitian tersebut mengungkapkan hubungan yang signifikan antara berbagai

aspek perawatan bayi seperti praktik menyusui dan kelengkapan imunisasi dan kejadian stunting. Secara khusus, praktik seperti pemberian ASI eksklusif dan imunisasi yang tepat dikaitkan dengan tingkat stunting yang lebih rendah (Nur *et al.*, 2021)

Prevalensi stunting sering kali diperburuk oleh faktor sosial ekonomi, termasuk pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan. Keluarga dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan untuk menyediakan nutrisi yang cukup, yang menyebabkan tingkat malnutrisi dan stunting yang lebih tinggi di antara anak-anak. Keluarga berencana yang efektif dapat membantu mengurangi masalah ini dengan memungkinkan keluarga mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dari waktu ke waktu (Flood *et al.*, 2019)

Proses pengambilan keputusan terkait keluarga berencana sering kali mencerminkan dinamika gender dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan memimpin dalam keputusan keluarga berencana dan pengasuhan anak, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam akses ke sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk praktik pengasuhan anak yang efektif. Mengatasi kesenjangan gender ini sangat penting untuk meningkatkan upaya keluarga berencana dan pada akhirnya mengurangi angka stunting.

KB memiliki hubungan yang jelas antara praktik keluarga berencana dan kejadian stunting di antara anak-anak. Dengan mempromosikan metode keluarga berencana yang efektif, meningkatkan jarak kelahiran, dan mengatasi hambatan sosial-ekonomi, masyarakat dapat meningkatkan hasil kesehatan anak secara signifikan. Mengintegrasikan pendidikan keluarga berencana dengan strategi gizi

menghadirkan pendekatan komprehensif untuk memerangi stunting secara global.

BAB 3

KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA BERENCANA

A. Peran KIE dalam Meningkatkan Kesadaran tentang KB.

Program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat perencanaan keluarga sangat penting, terutama dalam konteks kesehatan ibu dan anak serta pencegahan stunting. Dalam banyak penelitian, terlihat bahwa edukasi yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan praktik terkait perencanaan keluarga, yang berdampak positif terhadap kesehatan anak.

Manfaat Perencanaan Keluarga (Fauzie Rahman dkk, 2024)

1. Kesehatan Ibu dan Anak

Program keluarga berencana (KB) berfokus pada pengaturan jumlah dan jarak kelahiran anak, yang sangat penting untuk kesehatan ibu. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keluarga yang baik dapat mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan kesehatan anak dengan mengurangi kemungkinan stunting. Stunting sendiri merupakan masalah gizi yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Dengan mengatur jarak kelahiran, ibu dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup bagi setiap anak

2. Edukasi sebagai Kunci

Edukasi tentang perencanaan keluarga membantu pasangan usia subur memahami berbagai metode kontrasepsi dan manfaatnya. Misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa penyuluhan tentang kontrasepsi secara signifikan meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur mengenai perencanaan keluarga. Dengan pengetahuan yang lebih baik, mereka lebih mampu membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi mereka.

3. Pencegahan Stunting (Yanti, E. M., Wirastri, 2023)

Edukasi juga berperan penting dalam pencegahan stunting. Keluarga yang teredukasi dengan baik mengenai gizi, pola makan sehat, dan praktik kebersihan memiliki kemampuan lebih baik untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan stunting [5][6]. Misalnya, pemahaman tentang pentingnya makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan mendukung pertumbuhannya.

Rekomendasi untuk Program Edukasi (Ernawati *et al.*, 2023)

1. Pendekatan Holistik

Program edukasi harus melibatkan pendekatan holistik yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk sikap dan perilaku positif dalam keluarga. Ini termasuk pengajaran tentang gizi seimbang, sanitasi, dan praktik kebersihan

2. Keterlibatan Komunitas

Melibatkan komunitas dalam program edukasi dapat menciptakan efek domino yang positif. Ketika satu keluarga mendapatkan pengetahuan baru, mereka dapat membagikannya kepada tetangga dan anggota komunitas lainnya, sehingga meningkatkan kesadaran secara keseluruhan

3. Evaluasi Berkelanjutan

Penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program edukasi untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu memastikan dampak jangka panjang dari program tersebut.

Program edukasi tentang perencanaan keluarga memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaatnya untuk kesehatan ibu dan anak serta pencegahan stunting. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengelola kesehatan reproduksi dan gizi anak, kita dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini secara efektif (Mandira *et al.*, 2020)

B. Metode Penyuluhan yang efektif

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan menjadi salah satu strategi penting. Metode penyuluhan yang efektif dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan. Berikut adalah beberapa macam metode penyuluhan kesehatan

1. Metode Penyuluhan Individu

Metode ini dilakukan secara langsung dengan pendekatan personal kepada individu. Contohnya adalah:

- a. Bimbingan dan Konseling: Memberikan informasi secara langsung kepada individu yang membutuhkan, sehingga dapat menjawab pertanyaan dan kekhawatiran mereka secara spesifik.
- b. Door-to-Door: Metode ini melibatkan tenaga kesehatan yang mendatangi rumah-rumah untuk memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini memiliki efektivitas lebih tinggi dalam meningkatkan pemahaman dibandingkan dengan metode kelompok (Indraprana KK *et al.*, 2023)

2. Metode Penyuluhan Kelompok

Penyuluhan kelompok melibatkan sekelompok orang dalam satu sesi edukasi. Beberapa teknik yang digunakan meliputi:

- a. Ceramah: Penyampaian informasi oleh seorang narasumber kepada kelompok besar. Metode ini cocok untuk kelompok besar dengan lebih dari 15 peserta
- b. Diskusi Kelompok: Metode ini memungkinkan peserta untuk berbagi pendapat dan pengalaman, sehingga menciptakan interaksi yang lebih dinamis

- c. Simulasi dan Bermain Peran: Teknik ini memungkinkan peserta untuk berlatih situasi nyata dalam konteks kesehatan, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan informasi dengan lebih baik.

3. Metode Didaktik dan Sokratik (RAHMA, 2021)

- a. Metode Didaktik: Merupakan pendekatan satu arah di mana penyuluh memberikan informasi tanpa banyak interaksi dari peserta. Ini cocok untuk situasi di mana informasi perlu disampaikan secara cepat dan jelas [3].
- b. Metode Sokratik: Melibatkan komunikasi dua arah, di mana peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Ini mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang disampaikan [6].

4. Penggunaan Media

Menggunakan media komunikasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan:

- a. Media Audiovisual: Seperti video, slide, atau poster, dapat membantu menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami
- b. Media Massa: Televisi, radio, dan media sosial dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyebarkan informasi kesehatan secara efektif

5. Metode Partisipatif

Mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyuluhan sangat penting. Misalnya:

- a. Brainstorming: Metode ini melibatkan semua peserta dalam menghasilkan ide-ide baru terkait isu kesehatan, sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap masalah tersebut [6].

- b. Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat memperluas jangkauan penyuluhan serta meningkatkan efektivitas program-program kesehatan

Penyuluhan kesehatan yang efektif memerlukan pemilihan metode yang tepat sesuai dengan konteks dan sasaran audiens. Dengan memanfaatkan berbagai metode seperti penyuluhan individu, kelompok, penggunaan media, serta pendekatan partisipatif, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat. Implementasi strategi-strategi ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Peningkatan akses terhadap informasi

Untuk meningkatkan akses informasi mengenai perencanaan keluarga dan pencegahan stunting di seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, beberapa strategi dan pendekatan dapat diterapkan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Digitalisasi dan Teknologi Informasi melalui pengembangan aplikasi dan platform digital. (Al Jihad *et al.*, 2022)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) untuk mendukung pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan data secara

real-time dan memberikan informasi kesehatan kepada calon pengantin serta keluarga. Dengan adanya kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi seperti Telkomsel, BKKBN berupaya memperluas jangkauan jaringan komunikasi di daerah terpencil, sehingga informasi dapat diakses dengan lebih mudah [1]. Selain itu juga bisa dilakukan edukasi Melalui Media Sosial dan Online. Informasi mengenai pencegahan stunting juga dapat disebarkan melalui platform media sosial dan website yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Penggunaan internet sebagai sarana edukasi memungkinkan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang gizi dan kesehatan anak.

2. Pendampingan Keluarga dan Komunitas (Latip and Malahayati, 2024)

BKKBN membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB untuk memberikan pendampingan langsung kepada keluarga. Tim ini bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan serta memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat. Dengan pendekatan berbasis keluarga, TPK dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap keluarga dan memberikan solusi yang sesuai. Pendidikan kesehatan yang melibatkan keluarga sangat penting dalam mencegah stunting. Program-program edukasi yang menysasar ibu hamil dan ibu dengan balita harus diperkuat untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung maupun pelatihan yang melibatkan masyarakat setempat. Selain

kader Kesehatan, kader keagamaan juga dapat mengambil peran dalam edukasi pencegahan stunting dan berkolaborasi dalam deteksi resiko stunting pada balita (Kusuma *et al.*, 2024)

3. Kolaborasi Multisektoral (Priyono, 2020)

Upaya pencegahan stunting memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat. Melalui pendekatan konvergensi, berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Misalnya, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai sangat penting dalam mendukung kesehatan anak. Inisiatif seperti Kampung Keluarga Berkualitas berfungsi sebagai platform untuk menerapkan lima pilar strategis dalam pencegahan stunting: gizi baik, perawatan kesehatan adekuat, akses air bersih, pendidikan masyarakat, dan perilaku hidup bersih. Program ini tidak hanya menyasar individu tetapi juga mengajak seluruh komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan stunting.

4. Mengatasi Tantangan Geografis (Rahman, Rahmah and Saribulan, 2023)

Kendala geografis di Indonesia sering kali menjadi tantangan dalam penyebaran informasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting untuk menjangkau daerah terpencil. Selain itu, pelatihan bagi kader kesehatan di daerah tersebut perlu ditingkatkan agar mereka mampu menyampaikan informasi dengan efektif kepada masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, akses informasi mengenai perencanaan keluarga dan pencegahan stunting dapat diperluas ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

BAB 4

KONSELING KELUARGA BERENCANA

A. Definisi Konseling Keluarga Berencana

Konseling keluarga berencana adalah upaya untuk memberikan informasi, bimbingan, dan dukungan kepada individu dan pasangan membantu individu membuat keputusan tentang kontrasepsi, kesuburan, dan perencanaan keluarga (WHO, 2018). Interaksi positif tentang KB, dilakukan antara calon peserta KB dan petugas membantu calon peserta KB mengenali kebutuhan cara KB serta memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada masa postpartum (Kesehatan and JHIPEGO, 2020). Proses interaksi tenaga kesehatan membantu klien untuk membuat pilihan secara sukarela tentang jumlah anak dan jarak kehamilan dalam keluarga setelah diberikan informasi (WHO, 2017). Konseling berpengaruh terhadap penggunaan KBPP (Kusuma, 2024)

B. Prinsip-prinsip konseling Keluarga Berencana (Sulistyawati, 2019)

Prinsip-prinsip konseling keluarga berencana sangat penting untuk memastikan bahwa proses konseling berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi klien. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan adalah prinsip dasar dalam konseling yang menjamin bahwa semua informasi yang dibagikan oleh klien selama sesi konseling akan dijaga kerahasiaannya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara konselor dan klien, sehingga klien merasa aman untuk berbagi informasi pribadi dan sensitif.

2. Pilihan Sukarela (Voluntary Choice)

Konseling keluarga berencana harus bersifat sukarela, di mana klien memiliki kebebasan untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Konselor harus menghormati keputusan klien dan tidak memaksakan pilihan tertentu.

3. Persetujuan yang Diberikan Secara Informasi (Informed Consent)

Sebelum memulai penggunaan metode kontrasepsi, klien harus diberikan informasi lengkap mengenai pilihan yang tersedia, termasuk manfaat, risiko, dan cara penggunaan. Klien harus memahami informasi ini sebelum memberikan persetujuan untuk melanjutkan.

4. Hak Klien (Client's Rights)

Setiap klien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kesehatan reproduksi dan pilihan kontrasepsi. Konselor harus menghormati hak-hak ini dan memastikan bahwa klien merasa dihargai dan didengar selama proses konseling.

5. Pemberdayaan (Empowerment)

Konseling bertujuan untuk memberdayakan klien agar dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan reproduksinya. Konselor harus membantu klien mengenali kebutuhan dan preferensinya serta memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan.

6. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi dua arah antara konselor dan klien sangat penting dalam proses konseling. Konselor harus mampu mendengarkan dengan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menjelaskan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh klien.

7. Pendekatan Holistik

Konseling keluarga berencana harus mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan budaya dari klien. Konselor perlu memahami konteks kehidupan klien untuk memberikan saran yang relevan dan sesuai dengan situasi mereka.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konseling keluarga berencana dapat dilakukan secara efektif, membantu klien dalam membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi mereka, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan [1][2][3].

C. Metode konseling Keluarga Berencana

Terdapat dua metode konseling KB yaitu Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Strategi Konseling Berimbang (SKB)

1. Konseling Metode Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)

a. Definisi

Konseling ABPK merupakan konseling Keluarga Berencana menggunakan media konseling flip chart ABPK untuk membantu klien memilih dan menggunakan alat kontrasepsi yang tepat melalui pemberian informasi. informasi tentang siapa yang dapat dan tidak dapat menggunakan setiap metode, efek samping, bagaimana menggunakan metode, kapan memulai, dan kapan kunjungan ulang (WHO, 2005).

b. Prinsip dan efektifitas konseling ABPK

Klien memberdayakan dirinya dengan membuat keputusan KB apa yang akan digunakan. Provider membantu klien mempertimbangkan dan membuat keputusan yang terbaik bagi klien menghormati keinginan klien. Tenaga kesehatan menanggapi pernyataan klien, pertanyaan, dan kebutuhan. Selain itu, juga mendengarkan apa yang dikatakan klien untuk mengetahui apa untuk dilakukan selanjutnya (WHO, 2005).

Penelitian yang dilakukan Herawati dkk 2018 penggunaan konseling ABPK pada masa hamil memengaruhi 0.6 x penggunaan KBPP masa postpartum (Herawati, et al., 2018). Gobel F dkk (2019) juga menjelaskan demikian (Gobel, 2019). Konseling

menggunakan ABPK juga meningkatkan kepuasan klien pada pelayanan KB (Farrokh, E *et al.*, 2014).

2. Informasi Cara Penggunaan Lembar Balik ABPK

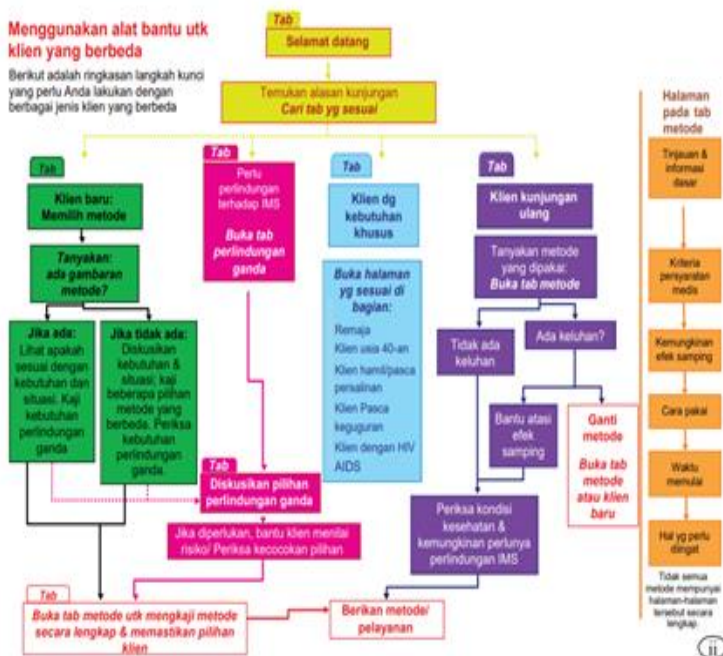
a. Bagian pertama

Bagian pertama ditandai dengan tab di sisi kanan. Tab ini bertujuan untuk memudahkan penyedia layanan dalam membantu klien sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat 5 buah tab dengan warna yang berbeda-beda untuk memudahkan penyedia layanan dalam menggunakan lembar balik ABPK. Tab berwarna kuning, yaitu tab Selamat Datang. Tab berwarna hijau, yaitu tab untuk membantu klien baru memilih metode KB. Tab berwarna merah, yaitu tab untuk membantu semua klien mendapatkan informasi mengenai perlindungan ganda, yaitu cara mencegah kehamilan dan perlindungan terhadap IMS dan HIV. Tabel berwarna biru, yaitu tab untuk membantu klien dengan kebutuhan khusus. Tab berwarna ungu, yaitu tab untuk membantu klien kunjungan ulang.



Gambar 4.1. Bagian Utama Lembar Balik ABPK

Referensi: Kemenkes, 2021. Pedoman Konseling Menggunakan Lembar Balik Alat Bantu Pengambilan Keputusan



Gambar 4.2. Halaman Informasi Cara Penggunaan Lembar Balik ABPK

Referensi: Kemenkes, 2021. Pedoman Konseling Menggunakan Lembar Balik Alat Bantu Pengambilan Keputusan

b. Bagian dua

Bagian dua ditandai dengan tab di sisi kiri bawah. Tab ini berisi informasi mengenai masing-masing metode KB yang dapat digunakan oleh penyedia layanan dalam membantu klien mengambil keputusan. Informasi yang tercantum di dalam tab-tab ini meliputi kriteria persyaratan medis, efek samping, cara pakai, waktu

kunjungan ulang, dan hal-hal lain yang perlu diingat serta didiskusikan dalam konseling KB

c. Bagian tiga

Bagian tiga yaitu tab tambahan yang berada di sisi kanan bawah. Tab ini berisi berbagai bantuan konseling yang dapat digunakan bila diperlukan, antara lain daftar tilik untuk memeriksa kemungkinan hamil bagi klien KB yang tidak/belum mendapat haid, perbandingan efektivitas metode KB, fakta tentang IMS dan HIV AIDS, sistem reproduksi perempuan, siklus haid, dan sebagainya.

3. Metode Strategi Konseling Berimbang

a. Definisi

Balanced Counseling Strategy (BCS)/ strategi konseling berimbang adalah strategi konseling yang praktis, interaktif, ramah klien yang menggunakan tiga alat bantu kerja utama (alat bantu memori visual) untuk konseling klien tentang keluarga berencana (León et al., 2015). Alat bantu kerja utama meliputi: Algoritma (*decision tree*) untuk membantu keputusan, kartu konseling yang berisi set metode KB, brosur yang sesuai untuk setiap metode (IAKMI, 2017).

b. Algoritma (*decision tree*) untuk membantu keputusan pilihan kontrasepsi (Population Council, 2015)

Terdiri dari beberapa tahapan meliputi tahap pra pemilihan metode, tahap pemilihan metode, tahap pasca pemilihan metode, dan tahap skrining untuk pelayanan lainnya:

Tahap pra pemilihan

- 1) Membangun dan mempertahankan hubungan yang hangat dan ramah.

- 2) Beritahu klien (dan pasangan, jika ada) bahwa akan ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan keluarga berencana selama konsultasi ini.
- 3) Tanyakan klien tentang jumlah keluarga saat ini dan penggunaan kontrasepsi saat ini. Konseling klien tentang waktu dan jarak kehamilan yang sehat dengan menggunakan kartu konseling.
 - a) Jika klien sedang menggunakan metode KB atau menunda kehamilan, tanyakan tentang kepuasannya dan minatnya untuk melanjutkan atau mengubah metode tersebut.
 - b) Jika pasangan hadir, gunakan layanan pria dan kartu dukungan.
- 4) Penapisan kondisi hamil dengan menggunakan daftar pemeriksaan untuk memastikan seorang perempuan tidak hamil
- 5) Tampilkan semua kartu metode. Tanyakan klien apakah dia menginginkan metode tertentu.
- 6) Ajukan semua pertanyaan berikut. Sisihkan kartu metode berdasarkan tanggapan klien.
 - a) Apakah anda ingin memiliki anak di masa depan?
 - b) Apakah anda pernah melahirkan dalam 48 jam terakhir?
 - c) Apakah anda menyusui bayi kurang dari 6 bulan?
 - d) Apakah pasangan anda mendukung anda dalam keluarga berencana?
 - e) Apakah anda memiliki kondisi medis tertentu?
Apakah anda minum obat?

Tahap pemilihan

- 1) Tinjau secara singkat metode yang dipilih dan tunjukkan keefektifannya.

- 2) Minta klien untuk memilih metode yang paling nyaman baginya.
- 3) Menggunakan brosur metode khusus, periksa apakah klien memiliki kondisi yang tidak disarankan untuk metode tersebut.

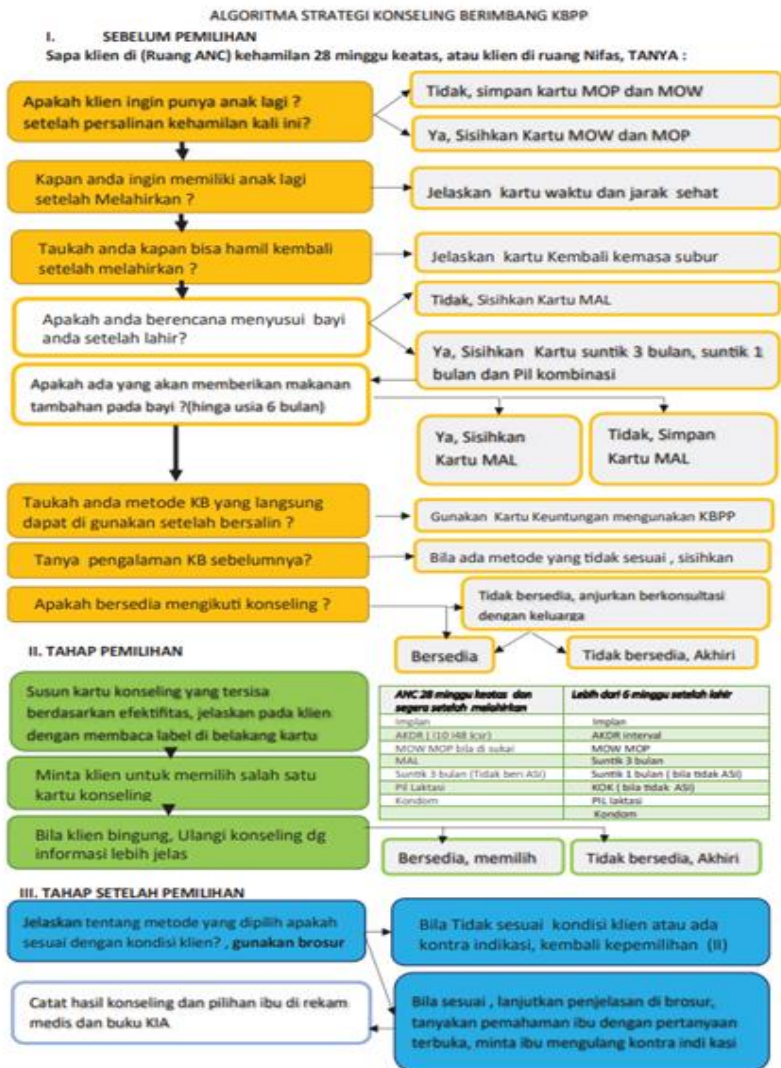
Tahap pasca pemilihan

- 1) Diskusikan metode yang dipilih dengan klien, dengan menggunakan brosur metode khusus sebagai alat konseling. Tenaga kesehatan menjelaskan secara komprehensif dan perkuat informasi kunci.
- 2) Pastikan klien telah membuat keputusan yang pasti. Klien dapat menyampaikan metode yang dipilih, rujukan, dan metode cadangan tergantung pada metode yang dipilih.
- 3) Mendorong klien untuk melibatkan pasangannya dalam pengambilan keputusan tentang/praktik kontrasepsi melalui diskusi atau kunjungan ke klinik.

Tahap skrining

- 1) Menggunakan informasi yang dikumpulkan sebelumnya, tentukan kebutuhan klien
- 2) Tanyakan kepada klien kapan dia melakukan skrining terakhir untuk kanker serviks (VIA/VILI atau pap smear) atau kanker payudara.
- 3) Diskusikan penularan dan pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) / *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan perlindungan ganda dengan klien menggunakan kartu konseling
- 4) Lakukan penilaian risiko IMS dan HIV dengan menggunakan kartu konseling. Jika gejalanya teridentifikasi, memberikan pengobatan secara sistemik.

- 5) Tanyakan kepada klien apakah dia mengetahui status HIV-nya.
- 6) Memberikan petunjuk tindak lanjut, brosur kondom, dan brosur metode yang dipilih. Tetapkan tanggal untuk kunjungan berikutnya.
- 7) Terima kasih atas kunjungannya. menyelesaikan sesi konseling.



Gambar 2.6 Algoritma metode Strategi Konseling Berimbang

Referensi : Kemenkes, 2020. Petunjuk Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan

- c. Kartu konseling, brosur, roda klop KB dan kategori kelayakan medis pada penggunaan kontrasepsi modern

Kartu konseling terdiri dari 17 kartu dengan 13 metode KB. Terdapat 5-7 pesan kunci. Kartu bergambar dan penjelasan sederhana tentang keefektifan metode. Mengikuti WHO MEC 2015. Terdapat 3 kartu tambahan meliputi : kembali subur, manfaat mengatur jarak kehamilan yang sehat. Keuntungan mendapatkan KBPP sebelum pulang. Terdapat kartu tambahan untuk klien ANC dan *immediate postpartum* sebelum pulang (IAKMI, 2017) (Council, 2017).

- d. Manfaat Strategi Konseling Berimbang

Manfaat SKB yaitu lebih dapat diandalkan karena memberikan gambaran yang detail. Mengambarkan keinginan dan perilaku yang di harapkan. Meminimalisir kesalahan dan bias dari petugas. Mengurangi pengulangan yang sering terjadi saat melakukan konseling. Memberikan layanan berkualitas yang berorientasi pada klien (IAKMI, 2017). Meningkatkan kualitas layanan khususnya pada interaksi petugas dan klien *Client Provider Interaction* (CPI) bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan klien terhadap metode yang dipilih, penggunaan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan tepat, tercapainya tujuan kesehatan reproduksi, seperti berhasil menjarangkan atau membatasi kehamilan (Kemenkes, 2018).

- e. Efektifitas Strategi Konseling Berimbang

Pengaruh Strategi Konseling Berimbang dalam menurunkan unmet needs postpartum lebih tinggi dibandingkan ABPK (Virawati DI, et al., 2020). Selain itu,

juga lebih tinggi pengaruhnya dalam meningkatkan cakupan kontrasepsi modern pada perempuan usia subur (Muslihah *et al*, 2021). Algoritma, kartu dan brosur konseling meningkatkan interaksi klien dan tenaga kesehatan sehingga klien dapat mengambil keputusan penggunaan KB dengan tepat sesuai kebutuhan (Leon et al., 2004).

D. Proses konseling

Proses konseling dapat dilakukan melalui beberapa model diantaranya OARS Model (Kassa, 2018) yaitu O- *Open-Ended Questions*, A – *Affirming*, R - *Reflective Listening*, S – *Summarizing*. SATU TUJU (Kemenkes and BKKBN, 2021) (Matahari, et al, 2018) meliputi SA – Salam, T – Tanya, U- Uraikan, TU- banTU, J- Jelas, U-Ulangan. REDI meliputi R - *Rapport Building*, E – *Exploration*, D – *Decision Making*, I – *Implementing Decision*. GATHER (Okour, et al., 2017) G – *Greet*, A – *Ask*, T – *Tell*, H – *Help*. E – *Explain*, R – *Return*.

Prinsip konseling (Family Planning National Training Center, 2015) yaitu membangun hubungan kepercayaan dengan klien. Menilai kebutuhan klien dan mempersonalisasi diskusi yang sesuai. Bekerja dengan klien secara interaktif untuk menetapkan rencana. Memberikan informasi yang dapat dipahami dan dipertahankan oleh klien. Informasi KB yang perlu disampaikan ke klien selama konseling yaitu *Method Information Index* yang meliputi informasi tentang macam-macam metode kontrasepsi, efek samping metode kontrasepsi dan apa yang perlu dilakukan apabila mengalami efek samping. Selain itu juga pengetahuan tentang hak reproduksi perempuan (BPS, 2018).

Terdapat beberapa kategori klien KB (USAID, 2008) meliputi klien baru dan sudah menentukan alat kontrasepsi

yang akan digunakan, klien baru belum menentukan pilihan, klien kunjungan ulang karena tidak puas dengan kontrasepsi yang digunakan, klien kunjungan ulang dan puas dengan kontrasepsi yang digunakan

BAB 5

MACAM-MACAM METODE KONTRASEPSI SEDERHANA

A. Metode Amenore Laktasi

Menurut Hubacher (2015), Metode Amenore Laktasi (MAL) merupakan salah satu metode kontrasepsi tidak modern. Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode keluarga berencana sementara yang sangat efektif untuk wanita menyusui. Metode Amenore Laktasi memberikan perlindungan alami terhadap kehamilan hingga enam bulan setelah kelahiran dan—sementara perempuan terus menyusui sesuai keinginannya—mendorong peralihan tepat waktu ke metode kontrasepsi modern lainnya.

Metode Amenore Laktasi didasarkan pada ketidaksuburan alami seorang wanita yang disebabkan oleh pemberian ASI saja (yaitu menyusui bayi sesering yang diinginkannya, siang dan malam, dan tidak memberikan makanan, air, atau cairan lain apa pun), serta tidak adanya perdarahan menstruasi selama enam bulan pertama setelah bayi lahir.

Mekanisme Kerja Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi dengan cara menyusui secara sering dan intensif melindungi wanita dari kehamilan dengan mencegah ovulasi. Tiga kriteria untuk dapat memenuhi metode MAL adalah sebagai berikut:

1. Wanita tidak menstruasi sejak bayinya lahir

Setelah melahirkan, kembalinya menstruasi merupakan sinyal penting bahwa kesuburan wanita telah kembali. Setelah wanita mulai menstruasi lagi, kemungkinan ovulasi juga telah terjadi lagi. Perlu dicatat bahwa perdarahan vagina selama dua bulan pertama pascapersalinan tidak dianggap sebagai perdarahan menstruasi.

2. Bayi hanya/eksklusif disusui

Ini berarti bahwa ASI adalah satu-satunya makanan atau cairan yang diberikan kepada bayi (selain vaksin, obat, atau tetes/teguk sesekali). Bayi harus disusui "sesuai permintaan", yang berarti bahwa setiap kali bayi menunjukkan tanda-tanda ingin disusui, baik siang maupun malam, ibu menyusui bayinya. Bayi tidak diberi dot, puting susu, atau empeng buatan. Semua kebutuhan nutrisi, rasa lapar, haus, dan isapan bayi terpenuhi dengan menyusui.

3. Bayi berusia kurang dari enam bulan

Pada usia 6 (enam) bulan, bayi harus mulai menerima makanan pendamping, sambil terus menyusui. Pemberian makanan pendamping dan/atau cairan dapat mengurangi isapan, sehingga mekanisme hormonal yang menyebabkan ovulasi dan menstruasi dapat kembali normal. (Georgetown University, 2009)

Meskipun penggunaannya terbatas pada enam bulan pertama pascapersalinan, LAM memberikan seorang wanita kontrasepsi yang sangat efektif (lebih dari 98% dari jumlah yang umum digunakan) dan berkontribusi terhadap kesehatan dan gizi bayinya. Periode waktu sebelum dan segera setelah kelahiran anak,

dan hingga enam bulan pascapersalinan, merupakan peluang berharga bagi wanita/pasangan untuk mempelajari dan memanfaatkan MAL untuk mencegah kehamilan.

Periode waktu ini juga merupakan titik masuk yang penting, atau “pintu gerbang”, menuju dimulainya metode keluarga berencana modern lainnya, yang memperluas perlindungan kontrasepsi berkelanjutan selama yang diinginkan oleh wanita/pasangan.

B. Suhu Basal Tubuh

Metode kontrasepsi dengan suhu basal tubuh adalah metode pengukuran suhu tubuh wanita selama ovulasi. Pengukuran suhu basal tubuh merupakan salah satu bentuk kesadaran perempuan yang terkait dengan kesuburannya. Pengukuran ini merupakan gambaran perubahan hormon perempuan berdasarkan siklus aktivitas ovarium selama bertahun-tahun. Suhu basal tubuh (SBT) adalah suhu tubuh Anda saat Anda benar-benar beristirahat. Suhu tubuh basal (SBT) adalah suhu terendah yang diukur saat bangun pagi. Pada kebanyakan wanita, suhu tubuh normal sedikit meningkat selama ovulasi (0,5–1°F) dan tetap tinggi hingga akhir siklus menstruasi. Hari-hari paling subur adalah 2–3 hari sebelum peningkatan suhu ini. Suhu akan tetap tinggi hingga periode berikutnya. Pengukuran SBT hanya menunjukkan saat ovulasi telah terjadi, bukan saat ovulasi akan terjadi. Perlu diingat juga bahwa jika Anda demam, metode SBT mungkin tidak dapat diandalkan. Prosedur SBT adalah sebagai berikut:

1. Suhu harus diukur pada waktu yang sama setiap hari
2. Suhu dapat diukur melalui mulut atau vagina tetapi harus dari tempat yang sama selama siklus

3. Suhu tubuh basal harus diukur segera setelah bangun tidur, sebelum bangun tidur dan sebelum makan, minum atau melakukan aktivitas lainnya
4. Masa subur berakhir ketika ada tiga hari berturut-turut suhu yang tercatat lebih tinggi dari enam hari sebelumnya. Setelah itu, hubungan seks tanpa pengaman dianggap aman.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Akurasi: termometer digital adalah yang terbaik
2. Suhu tubuh dapat meningkat karena sejumlah faktor tambahan seperti penyakit, alkohol, tidur lebih lama dari biasanya, kurang tidur, dan selimut listrik
3. Metode ini saja mungkin memerlukan pantangan selama beberapa hari. (<https://www.acog.org/womens-health/faqs/fertility-awareness-based-methods-of-family-planning> dan <https://www.fpnsw.org.au/health-information/contraception/fertility-awareness-based-methods-contraception-lactational>)

C. Senggama terputus (Coitus interruptus/withdrawal)

Coitus interruptus, juga dikenal sebagai senggama terputus, adalah metode kontrasepsi di mana penis dikeluarkan sepenuhnya dari vagina dan menjauh dari alat kelamin luar sebelum ejakulasi. Coitus interruptus mencegah sperma memasuki vagina, sehingga mencegah kontak antara spermatozoa dan sel telur. Senggama terputus merupakan salah satu metode kontrasepsi pada pria yang utama. Komunitas medis tidak menyarankan metode ini karena dianggap tidak efektif. Metode ini membutuhkan ketekunan dan kecakapan yang relatif tinggi. (Sartorius, 2024 dan <https://www.cdc.gov/contraception/hcp/usmec/coitus-interruptus-withdrawal.html>)

Senggama terputus tidak memiliki risiko kesehatan yang terkait langsung. Metode ini tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual (IMS), termasuk infeksi HIV. Walaupun metode kontrasepsi ini yang paling tidak efektif. Namun, beberapa pria menggunakan metode ini secara efektif, memberikan perlindungan kehamilan yang lebih baik daripada tidak menggunakan metode sama sekali serta selalu tersedia dalam setiap situasi. Dapat digunakan sebagai metode utama atau sebagai metode cadangan. Selain itu, metode ini tidak memerlukan perlengkapan dan tidak perlu mengunjungi klinik atau apotek. Keterlibatan pria dan komunikasi pasangan dapat meningkat dengan metode ini. (WHO, 2022)

Senggama terputus membutuhkan kecakapan seksual pada laki-laki. Penelitian Horner (2009), senggama terputus dapat kecakapan seksual pada remaja laki-laki, dipandang sebagai peningkatan kepercayaan dan kepedulian dalam hubungan yang stabil, dan dipandang sebagai pengurangan risiko kehamilan. Selain itu, remaja tersebut menyadari bahwa metode ini tidak dapat melindungi dari infeksi penyakit menular seksual (IMS).

Bagi pria yang menggunakan metode ini menyatakan bahwa metode ini gampang dan praktis. Metode ini dianggap sebagai keterlibatan pria dalam tanggung jawab dalam perencanaan keluarga dan melindungi istri dari efek samping kontrasepsi (Ortayli, 2005).

D. Sistem Kalender

Metode ini meliputi metode ritme kalender dan metode hari standar, dan melibatkan penghitungan hari-hari subur menggunakan tanggal-tanggal siklus bulan

sebelumnya. Metode ini paling baik digunakan setelah mencatat setidaknya tiga panjang siklus.

Hari pertama periode menstruasi dihitung sebagai hari pertama siklus. Panjang siklus diukur dari awal satu periode hingga sehari sebelum dimulainya periode berikutnya. Setelah meninjau tiga panjang siklus, wanita tersebut memilih siklus terpendek dan terpanjang. Metode ini harus dinilai ulang secara berkala, terutama jika panjang siklusnya bervariasi. Cara metode ritme kalender adalah sebagai berikut: pilih panjang siklus terpendek dan terpanjang, kurangi 21 dari siklus terpendek dan kurangi 10 dari siklus terpanjang. Misalnya, untuk wanita yang siklusnya bervariasi antara 26-30 hari: siklus terpendek: $26-21=5$ dan siklus terpanjang: $30-10=20$. Hari-hari suburnya adalah antara hari ke-5 dan ke-20, dan dia tidak boleh melakukan hubungan seks tanpa kondom pada hari-hari tersebut. Dalam siklus teratur perhitungannya sama. Misalnya dalam siklus teratur 28 hari, hari-hari suburnya adalah hari ke-7 hingga ke-18. (<https://www.fpnsw.org.au/health-information/contraception/fertility-awareness-based-methods-contraception-lactational>)

Semua wanita dapat menggunakan metode berbasis kalender. Tidak ada kondisi medis yang mencegah penggunaan metode ini, tetapi beberapa kondisi dapat mempersulit penggunaannya secara efektif. Perhatian berarti bahwa konseling tambahan atau khusus mungkin diperlukan untuk memastikan penggunaan metode yang benar. Penundaan berarti bahwa penggunaan metode kesadaran kesuburan tertentu harus ditunda hingga kondisinya dievaluasi atau diperbaiki. Berikan klien metode lain untuk digunakan hingga ia dapat memulai metode berbasis kalender. (WHO, 2022)

Hari ovulasi sangat bervariasi untuk setiap panjang siklus menstruasi, sehingga tidak mungkin metode kalender/aplikasi yang menggunakan informasi panjang siklus saja dapat secara akurat memprediksi hari ovulasi. Sebaiknya digunakan kombinasi dengan metode lain. (Johnson, 2018)

E. Lendir Serviks

Metode lendir serviks adalah salah satu metode berbasis kesadaran kesuburan. “Kesadaran kesuburan” berarti bahwa seorang wanita tahu cara mengetahui kapan masa subur siklus menstruasinya dimulai dan berakhir. Masa subur adalah saat dia bisa hamil. Kadang-kadang disebut pantang berkala atau perencanaan keluarga alami. Seorang wanita dapat menggunakan beberapa cara, sendiri atau dalam kombinasi, untuk mengetahui kapan masa suburnya dimulai dan berakhir. Metode berbasis kesadaran kesuburan berfungsi sebagai alat yang berguna bagi orang untuk melacak pengamatan eksternal harian yang mencerminkan ovulasi dan perubahan hormonal internal yang dialami wanita sepanjang siklus mereka. Penelitian Han (2017) menunjukkan bahwa lendir serviks berpotensi menjadi target kontrasepsi dengan karakteristik unik dan multiguna. Namun, keterbatasan metodologis yang terkait dengan penilaian klinis lendir serviks mempersulit pemahaman kita tentang efek pengobatan kontrasepsi. (Duane, 2022; WHO, 2022; Han, 2017)

Metode lendir serviks melibatkan pengenalan perubahan pada lendir yang diproduksi oleh serviks dan bagaimana lendir tersebut terlihat dan terasa. Tepat sebelum

ovulasi, jumlah lendir yang dibuat oleh serviks meningkat secara nyata, dan lendir menjadi encer dan licin. Tepat setelah ovulasi, jumlah lendir berkurang, dan menjadi lebih kental dan tidak terlalu terlihat. Untuk mencegah kehamilan, Anda harus menghindari hubungan seksual atau menggunakan metode kontrasepsi penghalang sejak pertama kali Anda melihat adanya lendir serviks. Saat menggunakan metode yang mengandalkan lendir serviks, waspadai perubahan apa pun dalam kesehatan atau rutinitas harian Anda yang dapat membuat tanda-tanda ovulasi menjadi sulit dibaca. Obat-obatan, produk kebersihan kewanitaan, douching, hubungan seksual, menyusui, atau menjalani pemeriksaan panggul yang menggunakan pelumas semuanya dapat mengubah tampilan lendir serviks. (<https://www.acog.org/womens-health/faqs/fertility-awareness-based-methods-of-family-planning>)

Metode ini melibatkan pengamatan variasi sekresi lendir serviks yang ditemukan di lubang vagina. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hari-hari subur karena perubahan hormon selama siklus wanita memengaruhi konsistensi sekresi yang terasa di lubang vagina. Lendir dibagi menjadi tiga pola berbeda:

1. Pola tidak subur pascamenstruasi: segera setelah menstruasi lubang vagina terasa kering, atau dengan lendir padat dan bersisik yang terasa lengket
2. Pola ovulasi atau subur: peningkatan kadar estrogen memberikan rasa basah di lubang vagina. Lendir menjadi bening, lebih encer dan elastis (tekstur seperti putih telur mentah)

3. Pola tidak subur pascamenstruasi: peningkatan kadar progesteron menyebabkan lendir menjadi keruh, lebih tebal dan lengket dan lubang vagina sekali lagi terasa kering. Hubungan seksual dapat dilanjutkan dengan aman setelah tiga hari 'kering' berturut-turut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) perlakukan pendarahan atau bercak selama siklus sebagai hari-hari yang berpotensi subur, dan (2) Gairah seksual, air mani, dan darah menstruasi dapat meniru atau menyembunyikan efek lendir subur, sehingga membuat interpretasi lendir menjadi lebih sulit.
- (<https://www.fpnsw.org.au/healthinformation/contraception/fertility-awareness-based-methods-contraception-lactational>)

F. Metode Simptotermal

Metode Simptotermal adalah metode kombinasi suhu basal tubuh, sekresi serviks, dan tanda kesuburan lainnya. Metode ini menggunakan pengamatan kombinasi dua atau lebih tanda kesuburan, termasuk suhu, sekresi lendir serviks, dan perubahan serviks, untuk menghitung masa subur dalam siklus. Dengan menggabungkan metode ini, akurasi identifikasi masa subur dan efektivitasnya meningkat. Metode ini merupakan salah satu metode berbasis kesadaran kesuburan (Genazzani, et. al, 2023; WHO, 2022 dan <https://www.fpnsw.org.au/healthinformation/contraception/fertility-awareness-based-methods-contraception-lactational>).

Kontrasepsi simptotermal atau metode berbasis kesadaran kesuburan (FABM) untuk keluarga berencana adalah metode pengendalian kelahiran yang dilakukan oleh

perempuan dengan mengumpulkan informasi untuk menginformasikan diri mereka sendiri tentang masa subur mereka, yaitu hari-hari dalam siklus dengan kesuburan tertinggi. Metode-metode ini bergantung pada pengamatan tanda-tanda dan gejala-gejala yang berkorelasi dengan kadar hormon yang berbeda sebagai indikator untuk perkiraan jangka waktu ketika ovulasi kemungkinan terjadi. Data yang umum dapat mencakup 1 atau lebih dari berikut ini: tanggal menstruasi, suhu tubuh basal (BBT), lendir atau posisi serviks, dan metabolit hormon urin. Karena pengumpulan data yang dibutuhkan pasien, kontrasepsi simptothermal umumnya disebut sebagai metode kontrasepsi "kesadaran kesuburan". (Peter, 2023)

BAB 6

MACAM-MACAM KONTRASEPSI MODERN

A. Kontrasepsi oral kombinasi

Pil yang mengandung dosis rendah dari 2 hormon—progestin dan estrogen—seperti hormon alami progesteron dan estrogen dalam tubuh wanita yang bekerja terutama dengan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium (ovulasi). Pil ini harus diminum setiap hari sebanyak 1 pil. Pil yang terlewat harus diminum sesegera mungkin. Pil yang terlewat berisiko mengganggu kehamilan dan dapat memperburuk risiko efek samping. (WHO, 2022)

Pil yang mengandung levonorgestrel atau noretisteron yang dikombinasikan dengan etinilestradiol 35 mikrogram atau kurang dianggap sebagai lini pertama. Pil tersebut efektif jika diminum dengan benar, memiliki risiko tromboemboli vena yang relatif rendah, dan tercantum dalam skema manfaat farmasi. Pil biasanya diminum dalam siklus bulanan. Beberapa wanita mungkin lebih menyukai rejimen pil yang diperpanjang dengan lebih sedikit atau tanpa pil yang tidak aktif. Pil kombinasi menawarkan perlindungan yang aman, efektif, dan reversibel terhadap kehamilan. (Stewart, 2015; Dragoman, 2014)

Kedua hormon tersebut bekerja sama untuk mencegah kehamilan terutama dengan menghentikan ovarium melepaskan sel telur setiap bulan. Pil KB juga membuat lendir di serviks lebih kental sehingga sperma tidak dapat masuk ke

rahim. Saat Anda mengonsumsi pil nonhormon, Anda akan mengalami pendarahan seperti saat menstruasi.

Jika digunakan dengan benar, pil KB efektif 99,5%. Dalam kehidupan nyata, efektivitasnya bisa jadi kurang (93%) jika Anda lupa meminumnya atau kehabisan pil. Pil biasanya mulai diminum dalam 5 hari pertama menstruasi alami saat pil tersebut langsung efektif. Dokter Anda mungkin menyarankan untuk mulai meminumnya di kemudian hari dalam siklus Anda yang disebut QuickStart, tetapi Anda harus menunggu selama 7 hari agar Pil tersebut mulai efektif. Atur pengingat di ponsel Anda atau letakkan kemasan pil Anda di samping sikat gigi Anda untuk membantu Anda mengingat untuk meminumnya pada waktu yang sama setiap hari.

<https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/contraception/combined-hormonal-contraceptive-pill>

B. Pil Progestin

Pil yang mengandung dosis progestin yang sangat rendah seperti hormon progesteron alami dalam tubuh wanita. Pil ini tidak mengandung estrogen, sehingga dapat digunakan selama menyusui dan oleh wanita yang tidak dapat menggunakan metode kontrasepsi dengan estrogen. Pil progestin saja (POP) juga disebut "pil mini" dan kontrasepsi oral progestin saja. Pil ini bekerja terutama dengan mengentalkan lendir serviks (ini menghalangi sperma bertemu sel telur) dan mengganggu siklus menstruasi, termasuk mencegah pelepasan sel telur dari ovarium (ovulasi). (WHO, 2022)

Pil progestin diminum satu pil setiap hari dan tidak ada jeda antar kemasan. Pil ini aman untuk ibu menyusui dan bayinya. Pil progestin saja tidak mempengaruhi produksi ASI. Perubahan perdarahan umum terjadi tetapi tidak berbahaya.

Biasanya, pil ini memperpanjang durasi tidak adanya perdarahan bulanan pada ibu menyusui. Bagi ibu yang mengalami perdarahan bulanan, perdarahan sering atau tidak teratur umum terjadi. Pil ini dapat diberikan kepada ibu kapan saja untuk mulai sekarang atau nanti. (WHO, 2022)

Efektivitas bergantung pada pengguna:

1. Bagi wanita yang mengalami perdarahan bulanan, risiko kehamilan paling besar jika pil diminum terlambat atau sama sekali tidak diminum.
2. Wanita menyusui:
 - a. Seperti yang umum digunakan, sekitar 1 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan POP selama tahun pertama. Ini berarti bahwa 99 dari setiap 100 wanita tidak akan hamil.
 - b. Bila pil diminum setiap hari, kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan POP selama tahun pertama (3 per 1.000 wanita).
3. Kurang efektif bagi wanita yang tidak menyusui: Seperti yang umum digunakan, sekitar 7 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan POP selama tahun pertama. Ini berarti bahwa 93 dari setiap 100 wanita tidak akan hamil. Bila pil diminum setiap hari pada waktu yang sama, kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan POP selama tahun pertama (3 per 1.000 wanita). Kembalinya kesuburan setelah POP dihentikan: Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual (IMS): (WHO, 2022)

C. Suntik Progestin

Progestin adalah bentuk progesteron, hormon yang berperan dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Progestin digunakan dalam beberapa metode kontrasepsi. Progestin

dapat diberikan dalam bentuk pil dan suntik. Suntikan ini sedikit lebih efektif daripada pil progestin saja. (<https://www.acog.org/womens-health/faqs/progestin-only-hormonal-birth-control-pill-and-injection>)

Kontrasepsi suntik depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) dan noretisteron enantat (NET-EN) masing-masing mengandung progestin seperti hormon progesteron alami dalam tubuh wanita. Kontrasepsi ini tidak mengandung estrogen, sehingga dapat digunakan selama menyusui, mulai 6 minggu setelah melahirkan, dan oleh wanita yang tidak dapat menggunakan metode yang mengandung estrogen. Setelah disuntikkan, hormon dilepaskan perlahan ke dalam aliran darah. Biasanya disuntikkan ke otot (injeksi intramuskular). Formulasi DMPA yang lebih baru dapat disuntikkan tepat di bawah kulit (injeksi subkutan). (WHO, 2022)

Suntikan KB melindungi dari kehamilan selama 13 minggu. Anda memerlukan empat suntikan setahun saat menggunakan bentuk KB ini. DMPA dalam suntikan ini memiliki beberapa efek yang bekerja sama untuk mencegah kehamilan: menghentikan ovulasi, mengentalkan dan mengurangi jumlah lendir serviks. Hal ini mempersulit sperma untuk memasuki rahim dan membuahi sel telur serta mengencerkan lapisan rahim. (<https://www.acog.org/womens-health/faqs/progestin-only-hormonal-birth-control-pill-and-injection>)

Efektivitas bergantung pada suntikan yang diberikan secara teratur: Risiko kehamilan paling besar terjadi jika seorang wanita lupa disuntik. Seperti yang umum digunakan, sekitar 4 kehamilan diharapkan terjadi per 100 wanita yang menggunakan suntikan progestin saja selama tahun pertama. Ini berarti bahwa 96 dari setiap 100 wanita yang

menggunakan suntikan tidak akan hamil. Jika wanita disuntik tepat waktu, kurang dari 1 kehamilan diharapkan terjadi per 100 wanita yang menggunakan suntikan progestin saja selama tahun pertama (secara spesifik, hanya 2 kehamilan yang diharapkan terjadi per 1.000 wanita yang menggunakan metode ini). Kembalinya kesuburan setelah suntikan dihentikan: Kesuburan membutuhkan waktu rata-rata sekitar 4 bulan lebih lama untuk kembali pada DMPA dan 1 bulan lebih lama pada NET-EN dibandingkan dengan sebagian besar metode lainnya. Metode ini tidak dapat melindungi risiko terhadap infeksi menular seksual (IMS). (WHO, 2022)

Penggunaan suntik DMPA sebagai alat kontrasepsi pada periode pasca persalinan terbukti merupakan metode alternatif yang aman dan efektif tanpa efek buruk pada ASI dan pertumbuhan bayi. (Singhal, et al, 2014)

D. Suntik Kombinasi

Suntikan bulanan mengandung 2 hormon—progestin dan estrogen—seperti hormon alami progesteron dan estrogen dalam tubuh wanita (Kontrasepsi oral kombinasi juga mengandung 2 jenis hormon ini) disebut juga kontrasepsi suntik kombinasi. Metode ini bekerja terutama dengan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium (ovulasi). (WHO, 2022)

Perubahan perdarahan umum terjadi tetapi tidak berbahaya. Biasanya, perdarahan bulanan lebih ringan, lebih sedikit hari perdarahan, atau perdarahan tidak teratur atau jarang. Kembalilah tepat waktu. Kembalilah setiap 4 minggu untuk mendapatkan efektivitas terbaik. Suntikan dapat dilakukan 7 hari lebih awal atau lebih lambat. Bahkan jika lebih lambat, ia mungkin masih bisa mendapatkan suntikan. (WHO, 2022)

Efektivitas bergantung pada pengembalian tepat waktu: Risiko kehamilan paling besar ketika seorang wanita terlambat untuk disuntik atau lupa disuntik. Seperti yang umum digunakan, sekitar 3 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan suntikan bulanan selama tahun pertama. Ini berarti bahwa 97 dari setiap 100 wanita yang menggunakan suntikan tidak akan hamil. Ketika wanita disuntik tepat waktu, kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan suntikan bulanan selama tahun pertama (5 per 10.000 wanita). Kembalinya kesuburan setelah suntikan dihentikan: Rata-rata sekitar 5 bulan, satu bulan lebih lama dibandingkan dengan sebagian besar metode lainnya (lihat Pertanyaan 11, hlm. 103). Perlindungan terhadap infeksi menular seksual (IMS): Tidak ada (WHO, 2022)

E. Intrauterine Device (IUD)

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) berbahan tembaga adalah rangka plastik kecil dan fleksibel dengan selongsong atau kawat tembaga di sekelilingnya. Penyedia layanan kesehatan yang terlatih khusus memasukkannya ke dalam rahim wanita melalui vagina dan serviks. Hampir semua jenis AKDR memiliki satu atau dua benang yang diikatkan padanya. Benang tersebut menggantung melalui serviks ke dalam vagina. (WHO, 2022)

Alat ini bekerja dengan menyebabkan perubahan kimia yang merusak sperma dan sel telur sebelum keduanya dapat bertemu. Metode ini dapat mencegah kehamilan pada jangka panjang. Selain itu, metode ini terbukti sangat efektif hingga 12 tahun, dapat segera dikembalikan. (WHO, 2022)

Metode IUD memerlukan tenaga terlatih untuk memasukkan alatnya ke dalam rahim. Klien hanya perlu sedikit bergerak setelah IUD terpasang. Biasanya terjadi

perubahan perdarahan. Biasanya, perdarahan lebih lama dan lebih banyak serta lebih banyak kram atau nyeri selama perdarahan bulanan, terutama pada 3 hingga 6 bulan pertama. (WHO, 2022).

F. Implant

Implan kontrasepsi adalah batang plastik kecil yang fleksibel, sekitar 4 cm panjangnya, yang dipasang oleh dokter atau perawat di bawah kulit lengan atas. Implan ini mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progestogen untuk menghentikan ovarium melepaskan sel telur setiap bulan. Implan kontrasepsi tidak cocok untuk semua orang. Implan bekerja selama 3-5 tahun, tergantung pada jenis implan, dan dapat segera dikembalikan seperti semula. Implan memiliki tingkat efektivitas lebih dari 99% jika diganti setiap 3 tahun. Jika tidak, implan tersebut kurang efektif. Dokter atau perawat yang terlatih khusus dapat melepas implan kapan saja jika Anda tidak ingin menggunakannya lagi. Setelah implan dilepas, peluang Anda untuk hamil akan kembali seperti sebelum implan dipasang. (WHO, 2022 dan <https://www.nhs.uk/contraception/methods-of-contraception/contraceptive-implant/what-is-it/>)

Implan bekerja terutama dengan cara mencegah pelepasan sel telur dari ovarium (ovulasi) dan mengentalkan lendir serviks (ini menghalangi sperma mencapai sel telur). Implan menghindari kesalahan pengguna dan masalah dengan pasokan ulang. Perubahan perdarahan umum terjadi tetapi tidak berbahaya. Biasanya, terjadi perdarahan tidak teratur yang berkepanjangan selama tahun pertama,

kemudian perdarahan lebih ringan, lebih teratur, perdarahan jarang, atau tidak ada perdarahan sama sekali. (WHO, 2022)

G. Sterilisasi Wanita

Sterilisasi wanita adalah jenis kontrasepsi permanen, di mana tuba falopi (penghubung antara ovarium dengan rahim) diblokir atau dipotong untuk menghentikan sperma bertemu sel telur yang disebut juga dengan tubektomi. Sterilisasi ini lebih dari 99% efektif dalam mencegah kehamilan dan tidak memengaruhi hormon sehingga tetap akan mengalami menstruasi. Metode ini ditujukan untuk memberikan perlindungan seumur hidup, permanen, dan sangat efektif terhadap kehamilan. Pembalikan biasanya tidak memungkinkan. Metode ini dilakukan oleh penyedia layanan yang terlatih secara khusus dengan melakukan pemeriksaan fisik dan pembedahan. Sterilisasi wanita tidak mempunyai efek samping jangka panjang. (WHO, 2022 dan <https://www.nhs.uk/contraception/methods-of-contraception/female-sterilisation/what-is-it/>)

Sterilisasi wanita diindikasikan jika diinginkan oleh pasien untuk kontrasepsi permanen; satu-satunya kontraindikasi absolut adalah kurangnya persetujuan yang diinformasikan dari pasien. Oleh karena itu, proses persetujuan harus menekankan sifat permanen dari prosedur dan meninjau seluruh spektrum pilihan kontrasepsi alternatif dengan fokus pada kontrasepsi reversibel jangka panjang (LARC), termasuk alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) dan implan kontrasepsi, yang keduanya memiliki tingkat kemanjuran yang serupa dengan teknik sterilisasi tuba tradisional. (Marino, 2024)

H. Sterilisasi Pria

Sterilisasi pria, atau vasektomi, adalah prosedur yang dilakukan pada pria yang akan mencegahnya menghamili wanita secara permanen. Vasektomi adalah prosedur rawat jalan yang dilakukan dengan anestesi lokal. Setelah anestesi lokal disuntikkan, penyedia layanan kesehatan kemudian membuat sayatan kecil (insisi) pada skrotum, kantung yang menahan testis atau "buah zakar". Vas deferens—dua saluran yang membawa sperma ke penis—kemudian dipotong, diikat, atau diblokir. Beberapa pria menjalani vasektomi tanpa pisau bedah, di mana, alih-alih memotong kulit skrotum, lubang yang sangat kecil dibuat. Saluran yang membawa sperma ditarik melalui lubang dan diikat serta dipotong. Vasektomi tanpa pisau bedah tidak memerlukan jahitan. (Office of Population Affairs Department of Health, 2014)

Sterilisasi pria bersifat permanen bagi pria yang tidak ingin punya anak lagi. Metode ini berfungsi dengan menutup setiap vas deferens, sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam air mani. Air mani dikeluarkan melalui ejakulasi, tetapi tidak dapat menyebabkan kehamilan. Selain itu, metode ini ditujukan untuk memberikan perlindungan seumur hidup, permanen, dan sangat efektif terhadap kehamilan. Pembalikan seperti semula biasanya tidak mungkin dilakukan. Pria atau pasangan harus menggunakan kondom atau metode kontrasepsi lain selama 3 bulan setelah vasektomi. Metode ini tidak memengaruhi kinerja seksual pria. (WHO, 2022)

BAB 7

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA STUNTING DAN INTERVENSI YANG DILAKUKAN

A. Definisi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar deviasi pertumbuhan yang ditetapkan yaitu <2 SD pada kurva pertumbuhan WHO sebagai akibat dari kekurangan asupan nutrisi dan atau infeksi berulang dalam 1000 HPK (WHO, 2020). Stunting menurut Kemenkes merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan disebabkan oleh akumulasi kekurangan nutri yang berlangsung lama mulai dari kehamilan hingga anak berusia 24 bulan (Kemenkes, 2022). Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah 5 tahun (balita) sebagai akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dalam waktu jangka waktu lama.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting secara mikro, meso dan makro.

Stunting merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan yang adekuat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya diharapkan dapat memberikan intervensi yang tepat dan akurat dalam pencegahan dan penanganan stunting.

1. Faktor mikro (individu dan keluarga)

Faktor mikro ini lebih disebabkan dari keadaan individu dan keluarga. Diantaranya kekurangan gizi, penyakit infeksi, status gizi ibu dan pola asuh pemberian makan pada balita. Berikut penjelasan faktor mikro berdasarkan hasil penelitian:

a. Kekurangan gizi

Masa balita membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan sehingga terhindar kekurangan gizi yang berisiko menyebabkan stunting pada balita. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi lahir dan stunting akan tampak pada bayi usia 2 tahun (Djauhari, 2017). Pemberian nutrisi pada masa bayi adalah dengan memberikan ASI eksklusif, dimana riwayat pemberian ASI eksklusif berhubungan dengan kejadian stunting (Sutarto dkk, 2018; Wijhati dkk, 2021). ASI mempunyai komposisi yang lengkap sehingga dapat memenuhi mikronutrien pada usia 0-6 bulan yang mencegah terjadinya kekurangan gizi pada balita (Djauhari, 2017). Komposisi ASI yang lengkap dan seimbang tersebut meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan antibodi.

Pemenuhan gizi selanjutnya setelah usia 6 bulan dengan memberikan makanan pendamping ASI (MP ASI) juga berpengaruh pada kejadian kekurangan gizi. Usia bayi yang semakin bertambah akan diikuti juga dengan penambahan nutrisinya. MPASI diberikan sejak bayi usia 6 bulan untuk menghindari kekurangan gizi (Zagora dkk, 2021). Keberhasilan MP ASI bergantung pada pola asuh, pengetahuan orang tua tentang MP ASI (Zogara dkk, 2021; Kopa dkk, 2021). Pola asuh dan

pengetahuan ini berkaitan dengan komposisi dari MP ASI yang belum sesuai dari kuantitas dan kualitasnya sehingga berpengaruh pada gizi balita (Ulfani, 2011). Komposisi MP ASI harus memenuhi kebutuhan bayi untuk tumbuh dan berkembang sehingga kekurangan gizi dapat dicegah.

b. Penyakit infeksi

Salah satu faktor risiko stunting adalah penyakit infeksi yang pernah dialami bayi. Penelitian menunjukkan riwayat penyakit infeksi pada bayi berisiko 3 sampai 8 kali lebih besar mengalami stunting daripada bayi yang tidak mempunyai riwayat penyakit infeksi (Sumartini, 2022; Nabuasa, 2024). Hal ini disebabkan karena ketika bayi mengalami infeksi maka ada gangguan penyerapan nutrisi, peningkatan kebutuhan energi saat sakit yang tidak terpenuhi serta adanya penurunan nafsu makan pada bayi (Aridiyah, 2015; Milward, 2017). Penyakit infeksi yang menyerang pencernaan, akan mengganggu kemampuan organ tubuh dalam menyerap nutrisi dikarenakan adanya peradangan pada usus. Makanan yang masuk ke usus tidak bisa diserap secara optimal, sedangkan pada saat sakit tubuh membutuhkan banyak energi untuk melawan infeksi. Jika kebutuhan energi tidak terpenuhi maka akan menyerap energi yang seharusnya diunakan untuk pertumbuhan. Oleh sebab itu pengobatan penyakit infeksi pada bayi harus dilakukan terlebih dahulu untuk mencegah kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan stunting.

c. Status gizi ibu

Status gizi ibu selama kehamilan berperan penting dalam tumbuh kembang anak, mulai dari janin, masa

bayi dan balita. Penelitian menunjukkan ibu hamil dengan status gizi kurang kemungkinan memiliki resiko 13 kali lebih besar mengalami stunting dan akan kesulitan dalam memenuhi nutrisi pada janinnya (Ruaida&Soumokil, 2018; Fitriani dkk, 2020). Kekurangan nutrisi pada ibu hamil terutama protein, zat besi serta mikronutrien, dimana zat-zat tersebut diperlukan untuk tumbuh kembang janin. Selain itu status gizi ibu juga berpengaruh pada berat badan lahir bayi, menurut penelitian berat badan lahir rendah cenderung lahir dari ibu hamil dengan status gizi kurang (Apriluana&Fikawati, 2018; Ruaida&Soumokil, 2018). BBLR merupakan faktor risiko mengalami stunting karena cadangan nutrisi tidak mencukupi sejak lahir.

Faktor risiko lain terkait dengan ibu hamil adalah usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua mempunyai risiko lebih tinggi mengalami gizi kurang. Jarak kelahiran yang berdekatan menyebabkan ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan organ tubuhnya, sehingga mengalami kekurangan gizi saat kehamilan berikutnya. Jarak yang pendek meningkatkan risiko stunting, walaupun secara statistik tidak berhubungan secara signifikan (Eliafiana&Fadilah, 2022). Status sosial ekonomi yang rendah cenderung mengalami kekurangan gizi berkaitan dengan daya beli makanan bergizi dan akses pelayanan kesehatan yang terbatas (Apriluana&Fikawati, 2018; Nabuasa, 2024).

d. Pola asuh pemberian makan pada balita

Pola asuh orang tua terkait dengan pemberian makan sangat penting dalam mencegah stunting. Asupan

nutrisi yang cukup dan tepat sejak dini dapat membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Kuantitas dan kualitas pemberian nutrisi perlu diperhatikan oleh orang tua untuk menunjang pertumbuhan anak. Penelitian menunjukkan pola asuh yang kurang baik berdampak pada status gizi yang kurang, hal ini berhubungan juga dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua (Noorhasanah&Tauhidah, 2021; Nabuasa, 2024). Pola asuh juga dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan di rumah, misalnya pemberian makanan yang tidak bervariasi (Nabuasa, 2024). Pola asuh ini juga meliputi kemampuan keluarga dalam memberikan perhatian dan dukungan dalam pemberian nutrisi pada balita.

2. Faktor meso (komunitas dan lingkungan)

Faktor meso merupakan faktor penyebab secara tidak langsung yaitu di komunitas dan lingkungan. Faktor meso terdiri dari akses terhadap pelayanan kesehatan, fasilitas sanitasi dan air bersih, pendapatan keluarga, kebiasaan makan di lingkungan sosial dan pendidikan dan ketrampilan penanaman ibu.

a. Akses terhadap layanan kesehatan

Akses layanan kesehatan yang terjangkau merupakan salah satu kunci untuk pencegahan stunting. Akses layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh jarak, transportasi, biaya, ketersediaan tenaga kesehatan, kualitas pelayanan dan sosial budaya. Kurangnya akses layanan kesehatan akan berdampak pada keterlambatan dalam deteksi dini stunting sehingga penanganan juga akan terlambat. Akses layanan ini juga berhubungan dengan akses informasi yang tidak lancar tentang edukasi pencegahan stunting,

dikarenakan jarak dan akses media informasi yang kurang. Peningkatan akses layanan kesehatan perlu ditingkatkan walaupun di Indonesia banyak hambatan, terutama letak geografis, terutama di daerah terpencil.

b. Fasilitas sanitasi dan air bersih

Menurut penelitian terdapat pengaruh antara sanitasi yang baik dengan kejadian stunting, sanitasi yang baik akan berpeluang 18 kali tidak mengalami stunting (Rima dkk, 2023). Kondisi lingkungan yang berhubungan dengan prevalensi stunting yaitu sumber air minum, fasilitas sanitasi dan pembuangan sampah (Nisa dkk, 2021). Hasil penelitian menunjukkan sanitasi penyediaan air bersih kurang baik akan memiliki peluang 2,7 kali lebih besar mengalami stunting (Nisa dkk, 2021). Sanitasi secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting dimana sanitasi yang buruk dapat menimbulkan penyakit infeksi, terutama pencernaan, dimana akan mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh sehingga berdampak pada kekurangan gizi dan berisiko terjadi stunting (Kuewa dkk, 2021; Dinyati, 2022).

c. Pendapatan keluarga

Pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Pendapatan keluarga yang rendah mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan pangan di keluarga (Illahi, 2017). Hal ini berhubungan juga dengan pekerjaan orang tua, dimana jenis pekerjaan orang tua juga menentukan pendapatan keluarga. Penelitian lain mengungkapkan bahwa pendapatan keluarga tidak berhubungan secara signifikan, ini terjadi karena tingkat pendapatan yang tinggi belum tentu mengkonsumsi makanan yang

berkualitas (Al Rahmad dkk, 2016; Langi dkk, 2019). Secara pendapatan, memang dapat memenuhi ketahanan pangan tetapi belum tentu mereka membeli makanan yang gizinya lengkap. Penelitian lain menyatakan bahwa permasalahan bayi dengan gizi kurang disebabkan adanya krisis ekonomi, dimana ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan keluarga. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi gizi secara kualitas dan kuantitas masih dominan sebagai faktor lain terjadinya stunting (Ramadhani putri, 2020; Oktaviani 2021).

d. Kebiasaan makan

Kebiasaan makan berkaitan dalam peningkatan angka stunting (Kumalasari&Wulandari, 2024). Kebiasaan makan dengan asupan gizi yang tidak cukup, frekuensi makan yang kurang, variasi makan, praktik pemberian makan serta pola makan yang tidak sehat (Rusyantia, 2018). Sebagian besar ibu memberikan makanan sesuai dengan kebiasaan di keluarga tanpa memperhatikan kualitas gizi. Kebiasaan makan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kebiasaan budaya yang ada di lingkungan sekitar serta pengaruh dari kebiasaan orang terdekat misalnya nenek (Cholique&Nasrulloh, 2020; Kumalasari&Wulandari, 2024). Kebiasaan makan berhubungan dengan pengasuhan dimana ibu memberikan makanan sesuai yang disukai anak, mudah didapatkan, terkadang hanya berupa kudapan (Sharma, 2019)

Beberapa penelitian menyatakan kebiasaan makan yang kurang tepat diterapkan oleh ibu balita, kurangnya perhatian ibu terhadap kesesuaian gizi belum menjadi prioritas (Kumalasari&Wulandari,

2024). Hal ini berhubungan juga dengan perilaku dalam pemberian makan pada anak yang menyesuaikan kebiasaan dirumah yaitu makan pagi, siang malam, tanpa ada menu tambahan di jeda waktu makan utama (Anggraini, 2014; Ningtyas, 2020). Pendidikan dan pengetahuan ibu tentang kebiasaan makan pada balita tidak menjamin pemberian makanan secara kualitas dan kuantitas (Ningsih dkk, 2023). Ibu dengan pendidikan dan pengetahuan tinggi seharusnya mempunyai kebiasaan makan yang baik, tetapi sekalipun sudah mengetahui tentang kebiasaan makan yang baik, ibu tidak menerapkan kebiasaan tersebut. Risiko stunting meningkat 1,96 kali lebih besar pada ibu yang tidak memberikan praktik kebiasaan makan yang baik (Nurmalasari&septiyani, 2019).

3. Faktor makro

Faktor makro dalam kejadian stunting berkaitan dengan sistem dan kebijakan yang ada di pemerintahan. Sistem dan kebijakan nasional tentunya mempunyai andil yang cukup krusial dalam upaya pencegahan dan penurunan kejadian stunting di Indonesia. Sistem dan kebijakan yang baik akan mengarahkan upaya pencegahan dan penurunan stunting lebih efektif, terpadu dan efisien. Hal ini tidak lepas juga dari peran serta dari berbagai sektor baik pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

Kebijakan berkaitan dengan gizi, kesehatan ibu dan anak serta pembangunan desa merupakan dasar ukum untuk upaya pencegahan dan penurunan stunting. Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting sebagai salah satu landasan hukum

program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Keberhasilan dari program tersebut tergantung dari masing-masing daerah dengan semua komponen pendukung program. Hasil penelitian evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di beberapa propinsi ditemukan proses pelaksanaan sudah berjalan tetapi belum semua tempat berhasil dengan optimal (Susanti dkk, 2023; Sari&Yusran, 2022; Rerey dkk, 2023; Ma'ruf&Zainal, 2022; Gusmiyati&Yusran, 2022). Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut belum berhasil secara optimal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting, tingkat pendidikan ibu, usia ibu yang belum cukup umur untuk mempunyai anak (Kurnia dkk, 2024).

Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Keadaan perekonomian negara berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk penyediaan makanan bergizi. Pendapatan yang rendah dan ketimpangan pendapatan di masyarakat menyebabkan adanya perbedaan daya beli yang mencolok terutama dalam penyediaan makanan bergizi. Masyarakat menengah kebawah (miskin) akan semakin sulit dalam membeli makanan yang bergizi. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga akan mengakibatkan pendapatan yang tidak merata sehingga masyarakat miskin tidak akan merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut (Nasrun&Rahmania, 2018; Rahmawati dkk, 2020; Karyati, 2021; Viezani&Isra, 2024).

Keadaan negara dengan inflasi tinggi, pengangguran yang banyak dan kebijakan fiskal dan

moneter merupakan faktor lain yang dapat berdampak pada masyarakat miskin. Keadaan tersebut dapat menyebabkan harga makanan pokok naik, sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Banyaknya pengangguran mengakibatkan berkurangnya pendapatan keluarga sehingga pemenuhan makanan bergizi tidak tercapai (Nasrun&Rahmania, 2018; Viezani&Isra, 2024).

Perubahan lingkungan secara tidak langsung dapat menyebabkan stunting pada anak. Perubahan lingkungan mencakup beberapa hal diantaranya perubahan iklim, polusi, sanitasi yang buruk serta ketersediaan air bersih.

Perubahan iklim merupakan salah satu perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan stunting anak. Perubahan iklim merupakan perubahan cuaca disuatu daerah meliputi suhu, kelembapan, awan, hujan dan sinar matahari (BMKG). Dampak dari perubahan iklim ini meliputi semua sektor yaitu ketahanan pangan, kualitas gizi, kesehatan dan sanitasi. dampak tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Perubahan iklim tersebut dapat mengakibatkan produksi pertanian dan perikanan menurun, kualitas dari bahan pangan juga menurun, sehingga ketersediaan bahan pangan berkurang di masyarakat. Daya beli juga menurun dikarenakan stok pangan berkurang mengakibatkan harga menjadi naik, masyarakat kurang mampu kesulitan memenuhi makanan yang bergizi. Selain itu perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko terjangkit penyakit yang mempengaruhi status gizi anak. Peningkatan suhu dan curah hujan menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare dan demam berdarah, sehingga

mengganggu penyerapan nutrisi (Suryawan dkk, 2019; Unicef, 2024).

Polusi merupakan dampak lain dari perubahan lingkungan, meliputi polusi udara, air dan tanah. Polusi udara terjadi ketika terjadi paparan udara yang tercemar baik didalam atau luar ruangan. Paparan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (C. Pun, 2021). Polutan yang terhirup oleh oleh anak-anak dapat terinfeksi, sehingga dapat menginfeksi saluran pernafasan. Paparan ini dapat menyebabkan kematian anak salah satunya pneumonia (He dkk, 2022). Penelitian menyatakan polusi udara berpengaruh terhadap metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan stunting (Sinharoy dkk, (2020). Gangguan metabolisme tubuh dan infeksi ini berkaitan dengan terganggunya penyerapan nutrisi pada tubuh anak.

Polusi air dan tanah merupakan pencemaran pada air bersih, tanah termasuk sanitasi yang kurang baik dapat mengganggu kesehatan secara umum. Penelitian menyatakan adanya pencemaran air pada sumber air minum tetapi tidak ada hubungan yang signifikan antara air minum yang sudah diolah dengan kejadian stunting (Indriyati dkk, 2024). selain itu ketidaklayakan pada pembuangan limbah dan pengelolaan sampah terdapat dilingkungan anak stunting. Kejadian diare juga berhubungan dengan pencemaran air dilingkungan masyarakat, sehingga dapat mengganggu penyerapan nutrisi (Arlian, 2024). Polusi tanah dapat berkontribusi sebagai penyebab stunting. Mekanisme polusi terhadap tanah yaitu tanah yang tercemar (bahan kimia dan logam) akan diserap oleh tanaman (sayur dan buah).

Stabilitas politik dan keamanan merupakan pondasi suatu negara untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting akan berjalan optimal jika keadaan politik dan keamanan stabil. Secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Stabilitas dan keamanan yang tidak stabil akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, implementasi program terhambat, penurunan pendapatan dan kemiskinan, infrastruktur yang tidak memadai dan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah terkait pelaksanaan program (Sibanda, 1998; Dixit, 2024). Kondisi politik dan keamanan perlu dijaga agar program dapat berjalan optimal untuk penurunan angka stunting.

C. Intervensi spesifik penanggulangan stunting

Intervensi spesifik pada stunting merupakan penanggulangan secara langsung pada penyebab stunting. Intervensi spesifik ini lebih ke arah kesehatan. Pemenuhan kebutuhan gizi pada 100 hari kehidupan merupakan salah satu program dari pemerintah Indonesia untuk pencegahan stunting. Pemenuhan gizi tersebut dimulai dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun.

Intervensi spesifik dalam penanggulangan stunting merupakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mengatasi penyebab langsung dari masalah gizi ini. Stunting, yang ditandai oleh pertumbuhan yang terhambat akibat kurangnya asupan nutrisi, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terfokus pada kelompok sasaran tertentu, seperti ibu hamil dan anak balita.

Intervensi spesifik pada stunting merupakan penanggulangan secara langsung pada penyebab stunting.

Intervensi spesifik ini lebih ke arah kesehatan. Intervensi spesifik bertujuan untuk pencegahan stunting dan memperbaiki pertumbuhan balita yang sudah stunting dengan pemenuhan gizi. Pemenuhan kebutuhan gizi pada 100 hari kehidupan merupakan salah satu program dari pemerintah Indonesia untuk pencegahan stunting. Pemenuhan gizi tersebut dimulai dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan balita yang sudah stunting diberikan intervensi peningkatan gizi, pemberian makanan tambahan, edukasi pada orang tua (parenting pola asuh), pencegahan infeksi dan pengobatan penyakit (Kemenkes, 2023).

Terdapat 11 intervensi spesifik (Kemenkes, 2023; Pratiwi, 2023) yaitu Skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil KEK, pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian MP ASI kaya protein hewani bagi baduta, tata laksana masalah gizi, peningkatan cakupan imunisasi, edukasi ibu hamil, remaja dan keluarga termasuk pemisahan bebas buang air besar sembarangan. Intervensi tersebut tentunya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak baik dari keluarga, masyarakat dan tenaga kesehatan, **Konsep Intervensi Spesifik**

Intervensi spesifik berfokus pada beberapa aspek kunci yang langsung mempengaruhi status gizi individu, di antaranya:

1. Asupan Makanan: Peningkatan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak.
2. Pencegahan Infeksi: Melalui imunisasi dan pengobatan penyakit menular, yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi.

3. Status Gizi Ibu: Memastikan bahwa ibu memiliki status gizi yang baik sebelum dan selama kehamilan, serta saat menyusui.
4. Kesehatan Lingkungan: Meningkatkan sanitasi dan akses terhadap air bersih untuk mencegah infeksi

Rincian Intervensi Spesifik

Berdasarkan berbagai sumber, terdapat beberapa intervensi spesifik yang telah diidentifikasi sebagai efektif dalam penanggulangan stunting:

1. Skrining Anemia : Mengidentifikasi dan mengobati anemia pada remaja putri dan ibu hamil.
2. Pemberian Suplementasi : Seperti vitamin A, zat besi, dan seng untuk mendukung pertumbuhan anak.
3. Pendidikan Gizi : Penyuluhan mengenai pola makan sehat dan pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak.
4. Pelatihan Keterampilan Memasak: Mengajarkan cara memasak makanan bergizi dengan bahan-bahan lokal

Intervensi spesifik merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mengurangi stunting. Dengan fokus pada peningkatan asupan gizi, pencegahan infeksi, dan pendidikan kesehatan, program-program ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan di Indonesia. Keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor serta komitmen dari pemerintah dan masyarakat.

D. Intervensi sensitive penanggulangan stunting

Intervensi sensitif dalam penanggulangan stunting berfokus pada penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak. Berbeda dengan intervensi

spesifik yang langsung menangani masalah gizi, intervensi sensitif mencakup berbagai aspek sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi pertumbuhan anak.

Intervensi sensitive merupakan penanggulangan terhadap penyebab secara tidak langsung seperti lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Upaya perbaikan lingkungan seperti sanitasi dan air bersih dapat menurunkan stunting. Selain itu perawatan dan pengobatan penyakit pada yang tepat, memberikan edukasi atau pendidikan tentang kesehatan anak dan pola asuh merupakan upaya tak langsung untuk mencegah dan penanggulangan stunting (Primanto, 2024; Khasanah, dkk, 2022).

Kebijakan pemerintah juga sebagai pondasi dasar untuk menurunkan angka stunting. Melalui program pencegahan stunting dan peningkatan pelayanan kesehatan serta perbaikan ekonomi secara menyeluruh, diharapkan kejadian stunting dapat ditekan dan melampaui target WHO (Primanto, 2024; Khasanah dkk, 2022).

Definisi Intervensi Sensitif

Intervensi sensitif adalah kegiatan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang tidak langsung menyebabkan stunting, seperti sanitasi, kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Menurut penelitian, intervensi ini berkontribusi sekitar 70% terhadap penurunan stunting, sementara intervensi spesifik menyumbang sekitar 30%.

Komponen Intervensi Sensitif

1. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi : Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Program penyediaan

sarana sanitasi dan air bersih di komunitas menjadi prioritas dalam intervensi ini.

2. Pelayanan Kesehatan: Memastikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk imunisasi dan perawatan kesehatan ibu dan anak, merupakan bagian integral dari intervensi sensitif. Ini membantu dalam pencegahan penyakit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.
3. Pendidikan Pengasuhan dan Gizi: Meningkatkan kesadaran orang tua tentang pola asuh yang baik dan pentingnya gizi seimbang sangat penting. Edukasi mengenai cara memberikan makanan bergizi dan praktik pengasuhan yang baik dapat membantu mencegah stunting.
4. Bantuan Sosial: Program bantuan sosial untuk keluarga berisiko stunting dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dengan lebih baik.

Pendekatan Multisektor

Intervensi sensitif memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Pendekatan terintegrasi ini memastikan bahwa semua faktor yang berkontribusi terhadap stunting ditangani secara holistik.

BAB 8

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

A. Keluarga Berencana dan Stunting

Penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa keluarga berencana berpengaruh terhadap kejadian stunting. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Perencanaan waktu, jarak, dan pembatasan kelahiran dapat meningkatkan status gizi wanita (Rana, M. J., & Goli, S., 2017). Status gizi perempuan pada saat hamil mempengaruhi nutrisi anak (Kurnia, 2023). Keluarga berencana adalah faktor yang berdampak besar dalam mempengaruhi kejadian stunting. (Vaivada, et. al, 2020)

Hasil penelitiannya sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi dikaitkan dengan pertumbuhan linier anak yang lebih baik dan lebih sedikit stunting anak di Guatemala (Flood, 2019). Kejadian stunting pada balita di Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya disebabkan oleh jumlah balita dalam rumah tangga (Anastasia, 2023; Tafesse, 2021). Stunting juga disebabkan oleh jumlah anggota keluarga (Wake, 2023; Geberselassie et.al, 2018) dan jarak kelahiran (Essilfie, 2024; Toma, 2023; Rana et al, 2019).

B. Kebijakan Program Bangga Kencana dan Stunting di Indonesia

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pemerintah mencanangkan yang sebelumnya Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), saat ini disebut sebagai Program Bangga Kencana yang merupakan kependekan dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. (Dinas Pemberdayaan Perempuan, P. A. dan P. P. dan K. B., 2024)

Program Bangga Kencana adalah program yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, dimana program ini mengarahkan bagaimana keluarga mempunyai rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas. Program Bangga Kencana yang merupakan kependekan dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jika ditilik dari program sebelumnya yaitu Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) praktis hanyalah soal perbedaan istilah semata, sedangkan esensinya tetap sama. Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) adalah program yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, dimana program ini mengarahkan bagaimana keluarga mempunyai rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehingga terbentuk keluarga-

keluarga yang berkualitas. Program Bangga Kencana memiliki 3 aspek, yaitu:

1. Keluarga

Aspek ini mencakup bagaimana membina keluarga balita dan anak, bagaimana membina keluarga remaja dan bagaimana membina keluarga lanjut usia (lansia)

2. Kependudukan

Aspek ini terkait grand desain kependudukan serta pelaksanaan pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada.

3. Keluarga Berencana (KB)

Aspek ini bukan hanya bicara masalah alat kontrasepsi suntik, pil, kondom dan sebagainya, tetapi di dalam KB juga mencakup bagaimana kesehatan reproduksi bisa dijaga. (Dinas Pemberdayaan Perempuan, P. A. dan P. P. dan K. B, 2024)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan menurut Peraturan Presiden Nomor: 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, prevalensi stunting yang masih tinggi merupakan salah satu isu strategis terkait pemenuhan layanan dasar yang tercantum dalam renstra BKKBN 2020-2024. (BKKBN, 2020a; BKKBN, 2020b).

Pelayanan KB pasca persalinan, Pendampingan Keluarga dan Stunting

Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan merupakan salah satu indikator dalam percepatan penurunan stunting (BKKBN, 2021). Keluarga Berencana Pasca Persalinan yang disingkat KBPP adalah pelayanan KB

yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari, dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. (peraturan No. 18 Tahun 2020)

Salah satu strategi percepatan penurunan stunting adalah adanya pendampingan keluarga. Pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko stunting.

Pendampingan keluarga pada masa persalinan penting untuk meningkatkan penggunaan KB pasca persalinan. Tim Pendamping Keluarga harus melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas. Pada tahap ini perlu segera dilakukan pencegahan kehamilan berikutnya melalui KB Pascapersalinan atau setidaknya dengan Metode Amenore Laktasi (MAL). Mengingat kehamilan dengan jarak yang sangat dekat mempunyai potensi 2 kali lebih besar resiko terjadinya stunting. (BKKBN, 2021)

Integrasi Program Keluarga Berencana (KB) dengan Program Gizi untuk menurunkan stunting

Integrasi Program Keluarga Berencana (KB) dengan Program Gizi untuk menurunkan stunting untuk menurunkan stunting sangat penting dilakukan. Keluarga berencana

berkontribusi terhadap peningkatan hasil gizi. (Starbird et al, 2016). Keluarga berencana (KB) memengaruhi gizi dalam berbagai cara langsung dan tidak langsung. Berikut dampak KB terhadap nutrisi adalah sebagai berikut: (Naik, R., & Smith, R., 2015).

1. Keluarga berencana dapat bermanfaat bagi ibu, bayi, dan anak-anak dengan membantu perempuan dan pasangan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan pada saat-saat paling sehat dalam hidup.
2. Jarak kelahiran yang tepat memungkinkan tubuh perempuan memulihkan diri dan mengisi kembali nutrisi penting dan menghasilkan hasil gizi yang lebih baik
3. Penelitian ini mengungkap bahwa ibu dengan jarak kelahiran setidaknya dua hingga tiga tahun dibanding ibu dengan jarak kelahiran kurang dari dua tahun memiliki risiko lebih rendah untuk memiliki anak stunting di bawah usia lima tahun. (Dhingra, S., & Pingali, P. L., 2021).
4. Keluarga berencana dapat membantu perempuan menghindari kehamilan berisiko tinggi dan memiliki anak pada saat-saat paling sehat dalam hidup, misalnya, saat mereka berusia 18–34 tahun dan cukup matang secara fisik dan psikologis untuk menjadi ibu (Musafaah and Eryando, 2024). Anak-anak yang lahir dari ibu remaja dibandingkan ibu dewasa memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. (Welch et al., 2024)
5. Keluarga Berencana dapat mengatur kehamilan sehingga kehamilan yang terjadi benar-benar diinginkan. Anak-anak dari kehamilan yang tidak diinginkan berisiko mengalami gizi buruk. Kehamilan yang direncanakan mempunyai peluang besar untuk niat melakukan air susu

ibu (ASI) eksklusif yang akan mengarah pada perbaikan gizi. (Ibrahim et al., 2023)

6. Keluarga berencana secara tidak langsung memengaruhi gizi melalui dampaknya pada praktik pemberian makan bayi dan anak kecil. Ketika kelahiran berjarak baik, ibu memiliki lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya untuk menyusui dan memberi makan bayi dan anak kecil mereka secara memadai. Interval kelahiran yang lebih panjang memiliki risiko yang rendah untuk terjadinya malnutrisi (Dewey, K. G., & Cohen, R. J., 2007). Keluarga berencana berhubungan dengan praktik pemberian makan anak. Sebagian besar ibu yang tidak baik dalam KB, praktik pemberian makan anak tidak baik. (Simbolon et al., 2022)
7. Keluarga berencana dapat berdampak tidak langsung pada gizi dengan mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja, yang memungkinkan mereka untuk tetap bersekolah dan menyelesaikan lebih banyak tahun pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi di kalangan wanita mengarah pada produktivitas, pemberdayaan, dan kendali sumber daya yang lebih besar—memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik yang pada akhirnya bermanfaat bagi kesehatan dan gizi anak-anak dan keluarga.

Hambatan kebijakan KB dalam penurunan stunting

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2019, median unmet need KB/kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (persentase pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun dan sedang tidak menggunakan alat dan metode KB, masih menginginkan

anak akan tetapi ditunda sampai dengan 2 tahun ke atas dan menyatakan tidak menginginkan anak lagi) di Indonesia sebesar 10,1%, masih diatas angka Asia Tenggara (8,9%) dan termasuk peringkat terbesar ke 4 dari 10 negara di Asia Tenggara (United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division, 2019; BKKBN, 2014). Khusus di kalangan ibu pasca persalinan, Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi di Indonesia juga rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya. (Wilopo, 2017).

Kurangnya akses KB adalah alasan umum untuk tidak menggunakan kontrasepsi (Bongaarts, 2014; Machiyama and Cleland, 2014; Moreira et al., 2019; Safitri and Siregar, 2019; Senderowicz and Maloney, 2022). Akses KB tidak hanya terkait akses fisik/geografi, tetapi juga akses ekonomi, akses informasi, akses administrasi, akses psikososial dan kualitas pelayanan (Bertrand et al., 1995; Welsh, 2006; Choi, Fabic and Adetunji, 2016). Akses geografis (Ariyanti, Dasuki and Wilopo, 2017) dan kualitas pelayanan (Safitri and Siregar, 2019; Aulia, Ramani and Baroya, 2020) berpengaruh terhadap unmet need KB di Indonesia.

Penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu jenis intervensi sensitif percepatan pencegahan stunting yang termasuk dalam kelompok intervensi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan (Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting, 2019). Salah satu cara untuk meningkatkan akses ke pelayanan KB adalah dengan meningkatkan penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelayanan KB. Jaminan kesehatan nasional (JKN) khususnya pada penerima Bantuan Iuran (PBI) berpeluang

meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern (Musafaah, M., & Eryando, T, 2023). Namun, sayangnya pelayanan KB dengan menggunakan JKN belum banyak, dapat dilihat dari kontribusi JKN untuk mendanai program KB di Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong rendah (Wahdi et al., 2023). Adanya JKN membantu mengurangi hambatan akses ekonomi untuk mendapatkan pelayanan KB pada PUS. Jaminan Kesehatan nasional (JKN) telah mengcover biaya pelayanan KB yang dapat meningkatkan akses KB khususnya dalam akses ekonomi. (August et al., 2016; Moniz et al., 2018).

BAB 9

PENUTUP

Buku monograf ini telah mengupas secara komprehensif mengenai peran perencanaan keluarga dalam upaya pencegahan stunting, dengan fokus pada masa pra-konsepsi yang menjadi kunci dalam mencegah masalah gizi kronis pada anak. Dalam setiap bab yang telah dibahas, mulai dari pentingnya perencanaan keluarga, kebijakan KB dan kependudukan, hingga metode kontrasepsi yang beragam, kita dapat melihat hubungan erat antara pengelolaan keluarga yang efektif dan pencegahan stunting.

Pada Bab 2, kami telah menguraikan bahwa perencanaan keluarga bukan hanya bertujuan untuk menekan angka kelahiran, tetapi juga untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi setiap pasangan yang ingin memiliki keturunan. Dalam hal ini, perencanaan keluarga berfungsi sebagai langkah preventif yang sangat penting, mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan jika perencanaan tersebut tidak dilakukan dengan bijaksana. Masa pra-konsepsi menjadi fase yang krusial, di mana kedua orang tua mempersiapkan tubuh mereka untuk menerima kehamilan dengan kondisi yang optimal, baik dari segi gizi, kesehatan, maupun psikologis.

Bab 3 menyoroti peran komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga. Melalui penyuluhan yang efektif dan peningkatan akses terhadap informasi yang akurat dan mudah dipahami, masyarakat dapat lebih paham tentang manfaat

perencanaan keluarga dan dampaknya terhadap kualitas kehidupan keluarga dan generasi berikutnya. KIE yang dilakukan secara tepat sasaran, berbasis bukti, dan dengan metode yang menyentuh kebutuhan masyarakat, dapat menjadi salah satu strategi yang ampuh dalam meminimalkan prevalensi stunting.

Bab 4 memperkenalkan konseling keluarga berencana (KB), yang menjadi salah satu aspek penting dalam penyuluhan. Konseling yang berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kerahasiaan, dan pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pasangan dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan adanya konseling, pasangan lebih dapat memahami berbagai pilihan kontrasepsi yang ada, serta manfaat dan risiko yang terkait, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

Dalam Bab 5 dan Bab 6, buku ini juga membahas berbagai metode kontrasepsi, baik yang sederhana maupun yang modern, yang dapat diakses oleh pasangan dalam rangka mengelola jumlah kelahiran dan merencanakan kehamilan dengan lebih matang. Pemilihan metode kontrasepsi yang tepat sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan, sosial, budaya, dan preferensi individu. Oleh karena itu, keberagaman metode kontrasepsi yang dipaparkan dalam buku ini diharapkan dapat memberi gambaran menyeluruh bagi masyarakat dalam memilih metode yang sesuai untuk mereka.

Secara keseluruhan, buku ini mengajak kita untuk menyadari bahwa perencanaan keluarga bukan hanya sekedar soal pengaturan kelahiran, tetapi juga sebagai langkah preventif yang harus dimulai jauh sebelum kehamilan itu terjadi, yakni pada masa pra-konsepsi. Melalui upaya perencanaan keluarga yang terarah, edukasi yang berkesinambungan, serta konseling yang profesional, kita dapat menciptakan generasi yang sehat

dan bebas dari stunting. Upaya pencegahan stunting memerlukan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat itu sendiri.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi referensi yang berguna dalam memperkuat upaya pencegahan stunting melalui perencanaan keluarga yang baik. Diharapkan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya perencanaan keluarga, maka kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia dapat semakin membaik, dan stunting dapat diminimalisir demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni'mah, Khoirun. Nadhiroh, Siti Rahayu. Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Media Gizi Indonesia, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2015; 13-19*
- Kemenkes. 2021. Peraturan Preseiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting
- Liza Syarifah.2023. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022: Jakarta
- Apriluana, Gladys. Fikawati, Sandra. Analisis factor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan Asia tenggara. *Media Litbangkes, Vol 28 No. 4, Desember 2018*
- Tebi, KDahlia, Eny Arlini Wello , Imran Safei, Rahmawati, Sri Juniarty, Akhmad Kadir. Litertur review factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak balita. *Fakumi Medical Journal; jurnal mahasiswa kedokteran Vol 1 No 3 Desember 2021. E-ISSN: 2808-9146*
- Supariasa, I D N. Purwaningsih Heni. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di kabupaten malang. *Karta Rahardja 1(2); 55-64, november 2019*
<http://ejournal.malangkah.go.id/index.php/kr>
- Al Jihad, M.N. *et al.* (2022) 'Cegah Stunting Berbasis Teknologi, Keluarga, Dan Masyarakat', *SALUTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), p. 31.
Available at:

<https://doi.org/10.26714/sjpkkm.v1i2.8683>.

BKKBN (2019) 'peraturan Kepala BKKBN No 27 tahun 2017'.

BKKBN, K. (2020) *Petunjuk Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan*. Available at: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/336019/setahun-pandemi-pernikahan-usia-dini-di-ngawi-terus-mengalami-kenaikan>.

Council, P. (2018) 'Brosure Balance Counseling', 2015 [Preprint].

DINI INDO VIRAWATI, Siswanto Agus Wilopo, Y.S.P. (2020) 'EFIKASI BALANCED COUNSELING PLUS PLUS PADA IBU HAMIL UNTUK MENURUNKAN UNMET NEED KB POSTPARTUM: RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL'.

Ernawati *et al.* (2023) 'Program Keluarga Berencana Melalui Edukasi Alat Haryati Bangsalan Teras Boyolali Prodi Kebidanan Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Prodi Promosi Kesehatan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan , Universitas Kusuma Penduduk Ind', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), pp. 21–26.

Family Planning National Training Center (2015) 'Principles for Providing Quality Counseling'.

Farrokh-Eslamlou, H. *et al.* (2014) 'Impact of the World Health Organization's decision-making tool for family planning clients and providers on the quality of family planning services in Iran', *Journal of Family Planning and Reproductive Health Care*, 40(2), pp. 89–95. Available at: <https://doi.org/10.1136/jfprhc-2012-100290>.

- Fauzie Rahman, Edi Setiawan, Syamsul Arifin, Yoga Putra Wibowo, Alfitri Chellyadiza, Angelia Ivana Palindangan Tambing, Dhiya Alfi Azizah, Helena Puteri Anggrainy, Nuraida Keisya Filsahani, Oktaviani Lativa Rahmadani, T.N. (2024) 'View of Peningkatan Pemahaman tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga pada Remaja Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* e-ISSN: 2745 4053 Vol. 6 No. 1, 2024 /pp: 498-506/DOI: <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4200> [Preprint].
- Flood, D. *et al.* (2019) 'Associations between contraception and stunting in Guatemala: Secondary analysis of the 2014-2015 Demographic and Health Survey', *BMJ Paediatrics Open*, 3(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2019-000510>.
- Gobel, F. (2019) 'Pengaruh Pemberian Konseling Dengan Alat Bantu Pengambilan Keputusan Terhadap Pemiliah Alat Kontrasepsi Pada Ibu Pasca Salin Di Rstn Boalemo', *Akademika: Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 8(1), p. 45. Available at: <https://doi.org/10.31314/akademika.v8i1.297>.
- Herawati, D., Wilopo, S.A. and Hakimi, M. (2018) 'Pengaruh konseling keluarga berencana menggunakan alat bantu pengambilan keputusan pada ibu hamil terhadap penggunaan kontrasepsi pasca persalinan: randomized controlled trials', *Tesis*, 34(11), pp. 411–415.

IAKMI (2017) 'Balanced Counseling Strategy (BCS) + Postpartum Family Planning'.

Indra, Frana, J. *et al.* (2023) 'Keefektifan metode penyuluhan door to door dan penyuluhan kelompok dalam upaya promosi kesehatan', *Lentera Perawat*, 4(2), pp. 123–130.

Indrawati, R. and Ulfiana, E. (2022) 'Analysis Of Factors Associated With The Use Of Postpartum Family Planning', *Jurnal Profesi Bidan Indonesia (JPBI)*, 2(2), pp. 2798–8856. Available at: <https://pbijournal.org/index.php/pbi>.

Kassa, M. (no date) 'QUALITY FAMILY PLANNING COUNSELING', *UNIVERSITY MICHIGAN 2017* [Preprint].

Kemenkes (2018) *Modul pelatihan Nakes Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana (SKB KB) untuk Dokter, Bidan, dan Perawat*.

Kementrian Kesehatan RI (2019) 'Undang-Undang Tentang Kebidanan No 4 Tahun 2019', *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, (004078), pp. 1–54.

Kesehatan, K., Indonesia, R. and BKKBN (no date) 'Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana', 2021 [Preprint].

Kesehatan, K. and JHIPEGO (2020) *Petunjuk Teknis Pelayanan Keluarga Berencana PascaPersalinan*.

Kusuma, I.R. *et al.* (2024) 'PENINGKATAN PERAN PENTAHILIX BAGI KADER ' AISYIAH UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI BANYUMAS', pp. 129–136.

Latip, L. and Malahayati, M. (2024) 'Peran Masyarakat Dalam Keluarga Berencana: Upaya Pencegahan Stunting Melalui Perencanaan Keluarga Masa Pra Konsepsi

Upaya Mencegah Stunting: Studi Kasus Di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Laksamana', *Jurnal Pesat: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIA LK*, 3(1), pp. 156–161. Available at: <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/>.

León, F. *et al.* (2015) 'The Balanced Counseling Strategy: A Toolkit for Family Planning Service Providers'.

Leon, F.R. *et al.* (2004) 'Population Council Knowledge Commons Effects of IGSS' job aids-assisted Balanced Counseling Algorithms on quality of care and client outcomes Recommended Citation', *Reproductive Health Social and Behavioral Science Research* [Preprint], (SBSR).

Mandira, T.M. *et al.* (2020) 'Edukasi Program Keluarga Berencana Pada Wanita Subur Selama Masa Pandemi Covid 19', *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), pp. 108–112. Available at: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan_Pelayanan_KB_dan_Kespro_Dalam_Situasi_Pandemi_COVID-19.pdf.

Matahari, R., Utami, F.P. and Sugiharti, S. (2018) 'Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi', *Pustaka Ilmu* [Preprint].

Muslihah, Lestari, M.W. and dan Yuliasuti, S. (2021) 'Perbedaan konseling KB menggunakan alat bantu pengambilan keputusan (ABPK) dan strategi konseling berimbang keluarga berencana (SKB-KB) terhadap cakupan akseptor KB', *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 5(1), pp. 19–23.

- Nur, R. *et al.* (2021) 'Effects of family planning and baby care behavior on stunting in early married couples', *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, pp. 467–473. Available at: <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5908>.
- Okour, A.M., Saadeh, R.A. and Zaqoul, M. (2017) 'Evaluation of family planning counselling in North Jordan', *Sultan Qaboos University Medical Journal*, 17(4), pp. e436–e443. Available at: <https://doi.org/10.18295/squmj.2017.17.04.010>.
- Population Council (2015) 'Algorithm for using the Balanced Counseling Strategy Plus', p. 2015.
- Priyono, P. (2020) 'Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)', *Jurnal Good Governance*, 16(2), pp. 149–174. Available at: <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>.
- RAHMA, E. (2021) 'Efektifitas Penggunaan Metode Penyuluhan Sokratik-Demonstrasi Dalam Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan Covid-19', *Excellent Midwifery Journal*, 4(1), pp. 83–90. Available at: <https://doi.org/10.55541/emj.v4i1.163>.
- Rahman, H., Rahmah, M. and Saribulan, N. (2023) 'Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), pp. 44–59.
- Stephenson, J. (2018) 'nutrition and lifestyle in the

preconception period and its importance for future health', *Lancet*, 391(10132), pp. 1830–1841. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30311-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30311-8).Before.

Stith Butler A, W.C.E. (2019) 'Overview of Family Planning in the United States - A Review of the HHS Family Planning Program - NCBI Bookshelf', *Washington (DC): National Academies Press (US)* [Preprint]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK215219/>.

USAID (2008) *Counseling for Effective Use of Family Planning Trainer 's Manual*.

WHO (2017) 'Family Planning Module 3 : Counselling for Family Planning'.

WHO, J.H. (2005) 'Decision Making Tool'.

World Health Organization (2022) *WHO guideline on self-care interventions for health and well-being, Geneva: World Health Organization*.

Yanti, E. M., Wirastris, D.& S. (2023) 'Edukasi Pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam meningkatkan Pengetahuan dan Pemilihan Alat Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Dusun Anjani Timur Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur', *Indonesian Journal of Community Dedication (IJCD)*, 5(1), pp. 7–12.

Al Jihad, M.N. *et al.* (2022) 'Cegah Stunting Berbasis Teknologi, Keluarga, Dan Masyarakat', *SALUTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), p. 31. Available at:

<https://doi.org/10.26714/sjpkkm.v1i2.8683>.

Ernawati *et al.* (2023) 'Program Keluarga Berencana Melalui Edukasi Alat Haryati Bangsalan Teras Boyolali Prodi Kebidanan Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Prodi Promosi Kesehatan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan , Universitas Kusuma Penduduk Ind', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), pp. 21–26.

Fauzie Rahman, Edi Setiawan, Syamsul Arifin, Yoga Putra Wibowo, Alfitri Chellyadiza, Angelia Ivana Palindangan Tambing, Dhiya Alfi Azizah, Helena Puteri Anggrainy, Nuraida Keisya Filsahani, Oktaviani Lativa Rahmadani, T.N. (2024) 'View of Peningkatan Pemahaman tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga pada Remaja Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* e-ISSN: 2745 4053 Vol. 6 No. 1, 2024 |pp: 498-506|DOI: <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4200> [Preprint]

Indraprana KK, I.F.J. *et al.* (2023) 'Keefektifan metode penyuluhan door to door dan penyuluhan kelompok dalam upaya promosi kesehatan', *Lentera Perawat*, 4(2), pp. 123–130.

Kusuma, I.R. *et al.* (2024) 'PENINGKATAN PERAN PENTAHILIX BAGI KADER ' AISYIYAH UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI BANYUMAS', pp. 129–136.

Latip, L. and Malahayati, M. (2024) 'Peran Masyarakat Dalam Upaya Mencegah Stunting: Studi Kasus Di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Laksamana',

Jurnal Pesat: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIA LK, 3(1), pp. 156–161. Available at: <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/>.

- Mandira, T.M. *et al.* (2020) 'Edukasi Program Keluarga Berencana Pada Wanita Subur Selama Masa Pandemi Covid 19', *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), pp. 108–112. Available at: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan_Pelayanan_KB_dan_Kespro_Dalam_Situasi_Pandemi_COVID-19.pdf.
- Priyono, P. (2020) 'Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)', *Jurnal Good Governance*, 16(2), pp. 149–174. Available at: <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>.
- RAHMA, E. (2021) 'Efektifitas Penggunaan Metode Penyuluhan Sokratik-Demonstrasi Dalam Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan Covid-19', *Excellent Midwifery Journal*, 4(1), pp. 83–90. Available at: <https://doi.org/10.55541/emj.v4i1.163>.
- Rahman, H., Rahmah, M. and Saribulan, N. (2023) 'Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), pp. 44–59.
- Yanti, E. M., Wirastri, D.& S. (2023) 'Edukasi Pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam meningkatkan Pengetahuan dan Pemilihan Alat Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Dusun Anjani Timur Desa Anjani

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur',
Indonesian Journal of Community Dedication (IJCD),
5(1), pp. 7–12.

Council, P. (no date) 'Brosure Balance Counseling', 2015
[Preprint].

DINI INDO VIRAWATI, Siswanto Agus Wilopo, Y.S.P. (2020)
'EFIKASI BALANCED COUNSELING PLUS PLUS PADA
IBU HAMIL UNTUK MENURUNKAN UNMET NEED
KB POSTPARTUM: RANDOMIZED CONTROLLED
TRIAL'.

Family Planning National Training Center (2015) 'Principles for
Providing Quality Counseling'.

Farrokh-Eslamlou, H. *et al.* (2014) 'Impact of the World Health
Organization's decision-making tool for family
planning clients and providers on the quality of
family planning services in Iran', *Journal of Family
Planning and Reproductive Health Care*, 40(2), pp.
89–95. Available at: <https://doi.org/10.1136/jfprhc-2012-100290>.

Gobel, F. (2019) 'Pengaruh Pemberian Konseling Dengan Alat
Bantu Pengambilan Keputusan Terhadap Pemilihat
Alat Kontrasepsi Pada Ibu Pasca Salin Di Rstn
Boalemo', *Akademika: Jurnal Ilmiah Media Publikasi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 8(1), p. 45.
Available at:
<https://doi.org/10.31314/akademika.v8i1.297>.

Herawati, D., Wilopo, S.A. and Hakimi, M. (2018) 'Pe n ga r u h
ko n s e l i n g k e l u a r g a b e r e n c a n a
menggunakan alat bantu pengambilan keputusan

pada ibu hamil terhadap penggunaan kontrasepsi pasca persalinan: randomized controlled trials', *Tesis*, 34(11), pp. 411–415.

IAKMI (2017) 'Balanced Counseling Strategy (BCS) + Postpartum Family Planning'.

Kassa, M. (no date) 'QUALITY FAMILY PLANNING COUNSELING', *UNIVERSITY MICHIGAN 2017* [Preprint].

Kemenkes (2018) *Modul pelatihan Nakes Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana (SKB KB) untuk Dokter, Bidan, dan Perawat*.

Kesehatan, K., Indonesia, R. and BKKBN (no date) 'Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana', 2021 [Preprint].

Kesehatan, K. and JHIPEGO (2020) *Petunjuk Teknis Pelayanan Keluarga Berencana PascaPersalinan*.

León, F. *et al.* (2015) 'The Balanced Counseling Strategy: A Toolkit for Family Planning Service Providers'.

Leon, F.R. *et al.* (2004) 'Population Council Knowledge Commons Effects of IGSS' job aids-assisted Balanced Counseling Algorithms on quality of care and client outcomes Recommended Citation', *Reproductive Health Social and Behavioral Science Research* [Preprint], (SBSR).

Matahari, R., Utami, F.P. and Sugiharti, S. (2018) 'Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi', *Pustaka Ilmu* [Preprint].

Muslihah, Lestari, M.W. and dan Yuliasuti, S. (2021) 'Perbedaan konseling KB menggunakan alat bantu

pengambilan keputusan (ABPK) dan strategi konseling berimbang keluarga berencana (SKB-KB) terhadap cakupan akseptor KB', *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 5(1), pp. 19–23.

Okour, A.M., Saadeh, R.A. and Zaqoul, M. (2017) 'Evaluation of family planning counselling in North Jordan', *Sultan Qaboos University Medical Journal*, 17(4), pp. e436–e443. Available at: <https://doi.org/10.18295/squmj.2017.17.04.010>.

Population Council (2015) 'Algorithm for using the Balanced Counseling Strategy Plus', p. 2015.

Sulistiyawati (2019) 'Konseling Keluarga Berencana', *Modul Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, 2(2), pp. 37–64.

USAID (2008) *Counseling for Effective Use of Family Planning Trainer 's Manual*.

WHO (2017) 'Family Planning Module 3 : Counselling for Family Planning'.

WHO, J.H. (2005) 'Decision Making Tool'.

Activity of Purification Extract of Mutmete Seed (*Myristica fragrans*) Against *Streptococcus Mutans* International Journal of Medicine and Health (IJMH) Vol. 1, No. 4 Desember 2022e ISSN: 2962-1178; p-ISSN: 2962-0880, Hal 107-115

Dewi, R., Minarni., M.Riza, M (2024) Nutmeg (*Myristica fragrans*) Extracts Accelerate Oral Mucosal Wound Healing In Vivo. *Angiogenesis, Inflammation & Therapeutics*.

- Gupta, A. D., Rajpurohit, D., & Khajuria, A. K. (2022). Phytochemicals and pharmacological activities of *Myristica fragrans* (nutmeg): A review. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 11(2), 62-70
- Gupta, A. D., Singh, V. K., & Kumar, P. (2024). Efficacy of nutmeg-based products in the management of periodontal diseases: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Periodontology*, 95(6), 715-729.
- Jangid, K., Wadhwa, S., & Sharma, V. (2021). Antibacterial activity of nutmeg (*Myristica fragrans*) against oral microorganisms: An in vitro study. *Journal of Indian Society of Periodontology*, 25(5), 415-419.
- Nagja, T., Vimal, K., & Sanjeev, A. (2017). *Myristica fragrans*: A comprehensive review. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 8(2), 27-30.
- Narasimhan, B., & Dhake, A. S. (2021). Antibiofilm activity of *Myristica fragrans* seed extract against oral pathogens. *Journal of Herbal Medicine*, 26, 10041
- Narasimhan, B., & Dhake, A. S. (2023). Antibacterial activity of *Myristica fragrans* seed extracts against oral pathogens: An in vitro study. *Journal of Ethnopharmacology*, 295, 115434.
- Kumar, P., Singh, V. K., & Singh, D. K. (2023). Clinical evaluation of a nutmeg oil-containing dentifrice on dentin hypersensitivity: A randomized controlled trial. *Journal of Clinical Periodontology*, 50(2), 199-208.
- Kumar, S., Sharma, R., & Rath, S. K. (2024). Anti-inflammatory effect of nutmeg and honey paste on experimental gingivitis in rats. *Journal of Ethnopharmacology*,

301, 115994.

- Lim, T. K. (2012). Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants: Volume 3, Fruits. SpringerScience & Business Media.
- Sharma, A., Agarwal, N., Srivastava, A., & Tiwari, R. K. (2023). Interaction between nutmeg essential oil and alcohol-based mouthwashes: A preliminary in vitro study. *Journal of Dental Sciences*, 18(3), 1022-1028.
- Shafiei, Z., Shuhairi, N. N., Md Fazly Shah Yap, N., Harry Sibungkil, C. A., & Latip, J. (2020). Antibacterial activity of *Myristica fragrans* against oral pathogens. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2020, 3916365.
- Sonavane, G. S., Sarveiya, V. P., Kasture, V. S., & Kasture, S. B. (2017). Anxiogenic activity of *Myristica fragrans* seeds. *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, 71(1-2), 239-244.
- Singh, Y. N., Singh, N. N., & Sharma, K. (2024). Potential interaction of nutmeg with anticoagulant medications: A case series and literature review. *Phytotherapy Research*, 38(6), 1205-1211.
- Tanaka, M., Toe, M., Nagata, H., Ojima, M., Kuboniwa, M., Shimizu, K., ... & Shizukuishi, S. (2022). Effect of nutmeg oil-containing mouthwash on oral malodor: A double-masked, randomized trial. *Journal of Periodontology*, 93(5), 664-671.
- U. Zogara, M. S. Loaloka, and M. G. Pantaleon, "FAKTOR IBU DAN WAKTU PEMBERIAN MPASI BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI BALITA DI KABUPATEN KUPANG," *Journal of Nutrition College*, vol. 10, no.

- 1, pp. 55-61, May. 2021. <https://doi.org/10.14710/jnc.v10i1.30246>
- Maria Theodora Apriani Iza Kopa, Diana Mirza Togubu, Akmal Novrian Syahrudin Al Gizzai Hubungan Pola Pemberian MPASI dengan Status Gizi Anak Usia 6-24 Bulan di Kabupaten Pangkep: Public Health Nutrition Journal Vol. 1, No. 2, Juli 2021 Page: 103-110
- Ulfani DH, Martianto D, Baliwati YF. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Kaitannya dengan Masalah Gizi Underweight, Stunted, dan Wasted di Indonesia: Pendekatan Ekologi Gizi. Jurnal Gizi dan Pangan. 2011; 6(1): 63-4
- Erwina Sumartini. Studi Literatur: Riwayat Penyakit Infeksi Dan Stunting Pada Balita Program Studi D-III Kebidanan, STIKes Respati, Tasikmalaya, Indonesia. JKM: Jurnal Kesehatan Mahardika Vol. 9, No. 1, March 2022 ISSN: 2355-0724, DOI: 10.54867/jkm.v9i1.101
- Aridiyah, FO., Rohmawaty, N., Ririanty, M. 2015. Faktor – Faktor yang mempengaruhi kejadian stunting anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan. Jurnal Pustaka Kesehatan
- Milward, D. 2017. Nutrition, infection and stunting: The roles of deficiencies of individual nutrients and food, and of inflammation, as determinants of reduced linear growth of children. Nutrition Research Reviews, 30(1),
- Wulandari FC, Susanti. Hubungan status gizi ibu saat hamil dengan kejadian stunting pada balita usia 0-24

- bulan di PKM kaligesing purworejo Jurnal komunikasi kesehatan (edisi23) Vol.12 No.02 (2021)
- Nilfar Ruaida, Octovina Soumokil. Hubungan Status Kek Ibu Hamil Dan Bblr Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas Tawiri Kota Ambon JKT, 2018;9(2):45-51
- Evy Noorhasanah, & Nor Isna Tauhidah. (2021). Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Stunting Anak Usia 12-59 Bulan . *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 4(1), 37–42. <https://doi.org/10.32584/jika.v4i1.959>
- Nabuasa, C. (2024). Hubungan Riwayat Pola Asuh, Pola Makan, Asupan Zat Gizi Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24 – 59 Bulan Di Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 13(1), 58-74. <https://doi.org/10.51556/ejpazih.v13i1.228>
- Kuewa, Y., Herawati, Sattu, M., Otoluwa, A. S., Lalusu, E. Y., & Dwicahya, B. (2021). Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Stunting pada Balita Di Desa Jayabakti Tahun 2021. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk: Public Health Journal*. <https://doi.org/10.51888/phj.v12i2.73>
- Dinyati, F. R. (2022). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
- Nisa, S., Lustiyati, E., & Fitriani, A. (2021). Sanitasi Penyediaan Air Bersih dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*

- Masyarakat Indonesia*, 2(1), 17-25.
<https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i1.47243>
- Rima Ida, Susaldi Susaldi, & Agustina Sari. (2023). Pengaruh Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, Sanitasi Dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang Kepulauan Seribu Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Gizi*, 1(3), 135–148.
<https://doi.org/10.55606/jikg.v1i3.1410>
- AL Rahmad, A., & Miko, A. (2016). KAJIAN STUNTING PADA ANAK BALITA BERDASARKAN POLA ASUH DAN PENDAPATAN KELUARGA DI KOTA BANDA ACEH. *Kesmas Indonesia*, 8(2), 63-79. Retrieved from <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/kesmasindo/article/view/151>
- Ramadhani Putri, A. . (2020). ASPEK POLA ASUH, POLA MAKAN, DAN PENDAPATAN KELUARGA PADA KEJADIAN STUNTING. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 6(1), 7-12.
<https://doi.org/10.22487/htj.v6i1.96>
- Langi, G., Harikedua, V., Purba, R., & Pelanginang, J. (2019). Asupan Zat Gizi Dan Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia 3-5 Tahun. *Jurnal GIZIDO*, 11(2), 51 - 56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47718/gizi.v11i2.762>
- Oktavia, R. (2021). HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI KELUARGA DENGAN KEJADIAN STUNTING . *Jurnal Medika Hutama*, 3(01 Oktober), 1616-1620. Retrieved from

<https://www.jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/327>

- Kumalasari, D., & Wulandari, U. (2024). Kebiasaan Makan pada Balita Stunting di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS*, 11(1), 28-34. <https://doi.org/10.33653/jkp.v11i1.1075>
- Sharma N, Ferguson EL, Upadhyay A, Zehner E, Filteau S, Pries AM. (2019). Perceptions of commercial snack food and beverages for infant and young child feeding: a mixed-methods study among caregivers in Kathmandu Valley, Nepal (serial online). *Matern Child Nutr*, 15(Suppl 4) :e12711
- Anggraini IR. (2014). Perilaku makan orang tua dengan kejadian. *Jurnal Keperawatan*, 5(2), 154–162.
- Choliq, D. Nasrulloh, M. (2020). Pencegahan stunting di medokan semampir Surabaya melalui modifikasi makanan pada anak. *Humanism Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(1), 31 40
- Rusyantia, A. (2018). Hubungan Kebiasaan Konsumsi Ikan dan Asupan Protein Hewani dengan Kejadian Stunting Batita di Pulau Pasaran Kotamadya Bandar Lampung: The Relationship between Fish Consumption Habits and Animal Protein Intake with the Toddler Stunting Event in Bandar Lampung Municipal Market. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 4(1), 67–71. <https://doi.org/10.33084/jsm.v4i1.352>
- Nurmalasari, Y., & Septiyani, D. F. (2019). Pola Asuh Ibu dengan Angka Kejadian Stunting Balita 6-59 Bulan. *Jurnal Kebidanan*, 5(4), 381-388.

- Rerey, H. F., Masrif, Morgan, M., & Wahyuni, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Asmat Provinsi. *jurnal ilmiah kebidanan dan kandungan*, Vol 14 No 4 (429-437)
- Susanti, S. B., Pramono, S., & Pramudiana, I. D. (2021). Implementasi Kebijakan Program Stunting Pada Puskesmas Lawir. Vol 1. No 3 (571-581)
- Ma'aruf, K., & zainal, a. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING. *Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang*, Vol 4,issue 1 (35-43)
- Sari, D. P., & Yusran, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek. *jurnal of civic education*, Vol 5 No 1 (90-100)
- EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI INDONESIA LITERATURE REVIEW: EVALUATION OF STUNTING PREVENTION PROGRAM POLICIESIN INDONESIA Erlin Kurnia 1,Hermas Pradipka,Mahligai Aulia Prawira Negara JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia Vol 3. (2) Oktober2024 ISSN. 2829-4939
- Karyati, Y. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Jumlah Stunting di 10 Wilayah Tertinggi Indonesia Tahun 2010-2019. *Journal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 101-108.
- Rahmawati, N. F., Fajar, N. A., Idris, H. (2020). Faktor sosial, ekonomi, dan pemanfaatan posyandu dengan kejadian stunting balita keluarga miskin penerima

- PKH di Palembang. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 23-33.
- Nasrun, M. A. (2020). HUBUNGAN INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN STUNTING DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1).
- C.Pun, V., Dowling, R., & Mehta, S. (2021). Ambient and household air pollution on early-life determinants of stunting—a systematic review and meta-analysis. *Environemntal Science and Pollution Research*, 26404-26412. doi:<https://doi.org/10.1007/s11356-021-13719-7>
- Sinharoy et al. (2020). Air pollution and stunting: a missing link? *The Lancet Global Health*, 472-475.
- Indriyati, Liestiana, and Wardiansyah Naim. 2024. "Analisis Air Minum Anak Stunting Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023". *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 19 (2), 245-60. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.392>.
- Arlan, L., Muchtar, F., & Mitha Fatrisya, W. (2024). Gambaran Kondisi Kesehatan Lingkungan Pada Rumah Tangga Dengan Balita Stunting Di Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Expertise*, 2(2), 22–34. <https://doi.org/10.31004/ijme.v2i2.35>
- Anastasia H, Hadju V, Hartono R, Samarang, Manjilala, Sirajuddin, et al. (2023) Determinants of stunting in children under five years old in South Sulawesi and West Sulawesi Province: 2013 and 2018 Indonesian Basic Health Survey. *PLoS ONE* 18(5):e0281962. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281962>

- Ariyanti, L., Dasuki, D., & Wilopo, S. A. (2017). Ketersediaan sumber daya kesehatan dan kebutuhan KB tidak terpenuhi (unmeet need): analisis tingkat provinsi Availability of health resources and unmet needs: a provincial level analysis. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(1), 49–54.
- Aulia, D. M., Ramani, A., & Baroya, N. (2020). Service Quality and Unmet Need for Family Planning in Childbearing-Age Women at Jambesari Darus Sholah Sub-District, Bondowoso Regency. *Unnes Journal of Public Health*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/ujph.v0i0.28815>
- August, E.M. et al. (2016). Projecting the unmet need and costs for contraception services after the affordable care act. *American Journal of Public Health*, 106(2), pp. 334–341. Available at: <https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302928>.
- BKKBN. (2020a). Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Bangga Kencana Tahun 2020 (R. F. Nur, A. Suwanto, & I. M. Dwipayama, Eds.). BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020b). Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 (Cetakan Pertama). BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2021). Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia: Training of Trainer (ToT) Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting bagi Fasilitator Tingkat Provinsi.

- Bertrand, J.T. et al. (1995). Access , Quality Of Care and Medical Barriers In Family Planning Programs. *International Family Planning Perspectives*, 21(2), pp. 64–69.
- Bongaarts, J. (2014) 'The Impact of Family Planning Programs on Unmet Need and Demand for Contraception', *Family Planning*, 45(2), pp. 247–262. Available at: <https://about.jstor.org/terms>.
- Choi, Y., Fabric, M.S. and Adetunji, J. (2016). Measuring Access to Family Planning: Conceptual Frameworks and DHS Data. *Studies in family planning*, 47(2), pp. 145–161. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2016.00059.x>.
- Dewey, K. G., & Cohen, R. J. (2007). Does birth spacing affect maternal or child nutritional status? A systematic literature review. *Maternal & Child Nutrition*, 3(3), 151–173. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2007.00092.x>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, P. A. dan P. P. dan K. B. (2024). *Profil Bangsa Kencana Tahun 2023*.
- Dhingra, S., & Pingali, P. L. (2021). Effects of short birth spacing on birth-order differences in child stunting: Evidence from India. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(8). <https://doi.org/10.1073/pnas.2017834118>
- Dragoman, M. v. (2014). The combined oral contraceptive pill-recent developments, risks and benefits. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics &*

Gynaecology, 28(6), 825–834.
<https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2014.06.003>

Duane, M., Stanford, J. B., Porucznik, C. A., & Vigil, P. (2022). Fertility Awareness-Based Methods for Women's Health and Family Planning. In *Frontiers in Medicine* (Vol. 9). Frontiers Media S.A.
<https://doi.org/10.3389/fmed.2022.858977>

Essilfie, G., Kofinti, R.E. & Asmah, E.E. Reducing stunting and underweight through mother's birth spacing: evidence from Ghana. *BMC Pregnancy Childbirth* 24, 624 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06824-1>

Flood, D., Petersen, A., Martinez, B., Chary, A., Austad, K., & Rohloff, P. (2019). Associations between contraception and stunting in Guatemala: secondary analysis of the 2014-2015 Demographic and Health Survey. *BMJ Paediatrics Open*, 3(1), e000510. <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2019-000510>

Geberselassie SB, Abebe SM, Melsew YA, Mutuku SM, Wassie MM (2018) Prevalence of stunting and its associated factors among children 6-59 months of age in Libo-Kemekem district, Northwest Ethiopia; A community based cross sectional study. *PLoS ONE* 13(5): e0195361.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195361>

Genazzani, A. R., Fidecicchi, T., Arduini, D., Giannini, A., & Simoncini, T. (2023). Hormonal and natural contraceptives: a review on efficacy and risks of different methods for an informed choice.

Gynecological Endocrinology, 39(1).
<https://doi.org/10.1080/09513590.2023.2247093>

Georgetown University, I. for R. H. (2009). Lactational Amenorrhea Method (LAM): A Learning Resource Package for Family Planning Service Providers and Trainers. Georgetown University.

<https://www.acog.org/womens-health/faqs/fertility-awareness-based-methods-of-family-planning>

<https://www.fpnsw.org.au/health-information/contraception/fertility-awareness-based-methods-contraception-lactational>

<https://www.cdc.gov/contraception/hcp/usmec/coitus-interruptus-withdrawal.html>

Han L, Taub R, Jensen JT. Cervical mucus and contraception: what we know and what we don't. *Contraception*. 2017 Nov;96(5):310-321. doi: 10.1016/j.contraception.2017.07.168. Epub 2017 Aug 8. PMID: 28801053.

Horner, J. R., Salazar, L. F., Romer, D., Venable, P. A., DiClemente, R., Carey, M. P., Valois, R. F., Stanton, B. F., & Brown, L. K. (2009). Withdrawal (coitus interruptus) as a sexual risk reduction strategy: perspectives from African-American adolescents. *Archives of Sexual Behavior*, 38(5), 779-787. <https://doi.org/10.1007/s10508-007-9304-y>

Ibrahim, H. A., Alshahrani, M. A., Al-Thubaity, D. D., Sayed, S. H., Almedhesh, S. A., & Elgzar, W. T. (2023). Associated Factors of Exclusive Breastfeeding Intention among

- Pregnant Women in Najran, Saudi Arabia. *Nutrients*, 15(13), 3051. <https://doi.org/10.3390/nu15133051>
- Johnson, S., Marriott, L. and Zinaman, M. (2018) 'Can apps and calendar methods predict ovulation with accuracy?', *Current Medical Research and Opinion*, 34(9), pp. 1587–1594. doi: 10.1080/03007995.2018.1475348.
- Kurnia, Y., & Ismarwati, I. (2023). Correlation between Nutritional Status of Mothers During Pregnancy and Stunting Incidence at the Age of 24-59 Months at Godean Health Center 1. *Jurnal Kebidanan*, 12(1), 61. <https://doi.org/10.26714/jk.12.1.2023.61-68>
- Machiyama, K. and Cleland, J. (2014) 'Unmet Need for Family Planning in Ghana: The Shifting Contributions of Lack of Access and Attitudinal Resistance', *Family Planning*, 45(2), pp. 203–226. Available at: <https://about.jstor.org/terms>
- Marino S, Canela CD, Jenkins SM, et al. Tubal Sterilization. [Updated 2024 Feb 16]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470377/>
- Moniz, M.H. et al. (2018). Association of Access to Family Planning Services with Medicaid Expansion among Female Enrollees in Michigan. *JAMA Network Open*, 1(4). Available at: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.1627>.
- Moreira, L.R. et al. (2019) 'Reasons for nonuse of contraceptive methods by women with demand for contraception

not satisfied: An assessment of low and middle-income countries using demographic and health surveys', *Reproductive Health*, 16(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0805-7>.

Musafaah, M. and Eryando, T. (2024) 'Modern Contraceptive Use of National Health Insurance Participants before and during the COVID-19 Pandemic in South Kalimantan, Indonesia: Using Data from the Official Website of the National Population and Family Planning Agency', *Acta Medica Philippina*, 58(14), pp. 77–85. Available at: <https://doi.org/10.47895/amp.vi0.5185>.

Naik, R., & Smith, R. (2015). Impacts of Family Planning on Nutrition. Futures Group, Health Policy Project.

Office of Population Affairs Department of Health. (2014). Male Sterilization- The Facts. <http://www.hhs.gov/opa/>

Ortayli, N., Bulut, A., Ozugurlu, M., & Cokar, M. (2005). Why withdrawal? Why not withdrawal? Men's perspectives. *Reproductive Health Matters*, 13(25), 164–173. [https://doi.org/10.1016/s0968-8080\(05\)25175-3](https://doi.org/10.1016/s0968-8080(05)25175-3)

Peters A, Mahdy H. Symptothermal Contraception. 2023 Nov 13. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 33231986.

Rana, M. J., Gautam, A., Goli, S., Uttamacharya, Reja, T., Nanda, P., Datta, N., & Verma, R. (2019). Planning of births and maternal, child health, and nutritional outcomes: recent evidence from India. *Public*

Health, 169, 14–25.
<https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.11.019>

Rana, M. J., & Goli, S. (2017). Family Planning and Its Association with Nutritional Status of Women: Investigation in Select South Asian Countries. *Indian Journal of Human Development*, 11(1), 56–75.
<https://doi.org/10.1177/0973703017712392>

Safitri, H. and Siregar, K.N. (2019). Access, Quality of Family Planning Service, and Unmet Need: A Systematic Review. in *The 6th International Conference on Public Health. Masters Program in Public Health, Graduate School, Universitas Sebelas Maret*, pp. 370–378. Available at:
<https://doi.org/10.26911/the6thicph-FP.04.20>.

Sartorius, G.A. and Reisman, Y. (2024) 'Chapter35: Male Contraception', in J. Bitzer and T.A. Mahmood (eds.) *Textbook of Contraception, Sexual and Reproductive Health*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 217–222.

Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024*. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Senderowicz, L., & Maloney, N. (2022). Supply-Side Versus Demand-Side Unmet Need: Implications for Family Planning Programs. *Population and Development Review*. <https://doi.org/10.1111/PADR.12478>.

Simbolon, D., Bathari, R. R., Rahmadewi, & Riastuti, F. (2022). Family Planning and Mother's Practice In Children's

Feeding In Bengkulu Province, Indonesia. *Kemas*, 18(1), 41–48.
<https://doi.org/10.15294/kemas.v18i1.27966>

Singhal, S., Sarda, N., Gupta, S., & Goel, S. (2014). Impact of injectable progestogen contraception in early puerperium on lactation and infant health. *Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR*, 8(3), 69–72. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2014/7775.4110>

Starbird, E., Norton, M., & Marcus, R. (2016). Investing in Family Planning: Key to Achieving the Sustainable Development Goals. *Global Health: Science and Practice*, 4(2), 191–210.
<https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374>

Stewart, M., & Black, K. (2015). Choosing a combined oral contraceptive pill. *Australian Prescriber*, 38(1), 6–11.
<https://doi.org/10.18773/austprescr.2015.002>

<https://www.nutritionintl.org/news/all-blog-posts/3-reasons-integrating-nutrition-family-planning-game-changer/>

Tafesse, T., Yoseph, A., Mayiso, K. et al. Factors associated with stunting among children aged 6–59 months in Bensa District, Sidama Region, South Ethiopia: unmatched case-control study. *BMC Pediatr* 21, 551 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12887-021-03029-9>

Toma, T.M., Andargie, K.T., Alula, R.A. et al. Factors associated with wasting and stunting among children aged 06–59 months in South Ari District, Southern Ethiopia: a community-based cross-sectional study. *BMC Nutr*

9, 34 (2023). <https://doi.org/10.1186/s40795-023-00683-3>

- Vaivada, T., Akseer, N., Akseer, S., Somaskandan, A., Stefopoulos, M., & Bhutta, Z. A. (2020). Stunting in childhood: an overview of global burden, trends, determinants, and drivers of decline. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 112(Suppl 2), 777S-791S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa159>
- Wahdi, A. E., Sutanto, E., Setyawan, A., Astrini, Y. P., Adani, N., Mardani, H., Maulana, N., Pattnaik, A., Trihono, T., & Wilopo, S. A. (2023). National health insurance contribution to family planning program funding in Indonesia: A fund flow analysis. *Gates Open Research*, 7, 105. <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.14642.2>
- Wake, S.K., Zewotir, T., Lulu, K. et al. Longitudinal trends and determinants of stunting among children aged 1–15 years. *Arch Public Health* 81, 60 (2023). <https://doi.org/10.1186/s13690-023-01090-7>
- Welch, C., Wong, C. K., Lelijveld, N., Kerac, M., & Wrottesley, S. v. (2024). Adolescent pregnancy is associated with child undernutrition: Systematic review and meta-analysis. *Maternal & Child Nutrition*, 20(1). <https://doi.org/10.1111/mcn.13569>
- Welsh, M.J. (2006). Access to modern contraception. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology*, 20(3), pp. 323–338. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2005.12.001>.

World Health Organization Department of Sexual and Reproductive Health and Research (WHO/SRH) and John Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs (CCP), K. S. (2022). Family Planning: A Global Handbook for Providers. CCP and WHO.

GLOSARIUM

A

ANC adalah *Ante Natal Care* yakni pemeriksaan selama kehamilan

ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) sebagai satu-satunya sumber nutrisi bagi bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan, tanpa memberikan makanan atau minuman lain, termasuk susu formula, air, atau makanan padat.

G

Gender adalah konsep yang merujuk pada perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, yang mencakup sifat, peran, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat.

I

IMS adalah infeksi menular seksual

Implan adalah batang plastik kecil yang fleksibel, sekitar 4 cm panjangnya, yang dipasang oleh dokter atau perawat di bawah kulit lengan atas untuk mencegah kehamilan

Intrauterine Device (IUD) adalah alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) berbahan tembaga.

K

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan.

Kontrasepsi oral kombinasi adalah kontrasepsi berupa pil yang mengandung dosis rendah dari 2 hormon—progestin dan estrogen untuk mencegah pelepasan sel telur dari ovarium (ovulasi).

M

MP-ASI adalah Makanan Pendamping-Air Susu Ibu

Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi dengan cara menyusui secara sering dan intensif melindungi wanita dari kehamilan dengan mencegah ovulasi.

Metode lendir serviks adalah pengamatan variasi sekresi lendir serviks yang ditemukan di lubang vagina untuk mengidentifikasi hari-hari subur.

Metode Simptotermal adalah metode kombinasi suhu, sekresi lendir serviks, dan perubahan serviks untuk menghitung masa subur dalam siklus.

P

PNC adalah *Post Natal Care* yaitu pemeriksaan pada masa postpartum

P4K adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yaitu program yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui perencanaan yang matang dan pencegahan komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas

Pil Progestin adalah pil yang mengandung dosis progestin yang sangat rendah dan bekerja terutama dengan mengentalkan lendir serviks

S

Standar deviasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran nilai dalam suatu kumpulan data.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar yang

ditetapkan, yaitu dengan nilai z-score kurang dari -2.00 SD untuk kategori stunted dan kurang dari -3.00 SD untuk severely stunted.

Senggama terputus adalah metode kontrasepsi di mana penis dikeluarkan sepenuhnya dari vagina dan menjauh dari alat kelamin luar sebelum ejakulasi.

Suntik kombinasi adalah suntikan bulanan mengandung 2 hormon—progestin dan estrogen—yang bekerja terutama dengan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium (ovulasi).

U

Unwanted Pregnancy adalah kehamilan yang tidak dikehendaki

V

Vasektomi adalah prosedur yang dilakukan pada pria yang akan mencegahnya menghamili wanita secara permanen dengan

W

WHO adalah *World Health Organization*

Z

z-score adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai (data) menyimpang dari rata-rata dalam satuan standar deviasi.

PROFIL PENULIS



Dr. Inggarratna Kusuma, S.ST., MPH.

Lahir di Magelang, 19 Maret XXXX. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis diawali dari Pendidikan D 3 lanjut hingga S 3 yaitu jenjang D3 pada Program Studi D III di Poltekkes Semarang tahun 2006, S1 pada Program Studi D 4 Kebidanan tahun 2009 dan S 2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 lulus tahun pada tahun 2024 di Universitas Indonesia. Lulus S2 dan S3 dengan predikat Cumlaude. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 sebagai asisten bidan di RB Lestari Magelang. Kemudian menjadi bidan di PPKM Muhammadiyah Magelang. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengampu mata kuliah Masa Antara dan KB, metodologi riset dan Kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Referensi Keluarga Berencana Berbasis Bukti, Pendidikan pada Masa Pandemi, Buku Soal UKOM bidan D 3, Buku Ajar Profesionalisme dalam Kebidanan dan Gerimis II. Penulis juga sudah mempublikasikan hasil penelitian di beberapa jurnal dan aktif di kegiatan pengabdian masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: inggaratnakusuma@ump.ac.id

Motto: "Berusaha menebar manfaat sebanyak banyaknya"

PROFIL PENULIS



Dr. Musafaah, SKM. MKM. Lahir di Jakarta, 20 April XXXX. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh, yaitu jenjang S1 pada peminatan Biostatistik dan Kependudukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Indonesia (UI) lulus tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada peminatan yang sama di FKM UI lulus tahun 2012 dan lulus S3 Ilmu Kesehatan

Masyarakat (IKM) di FKM UI pada tahun 2024. Saat ini, penulis bekerja sebagai dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM) Program Sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan. Penulis mengampu mata kuliah Biostatistik, Manajemen Data, Sistem Informasi Pangan dan Gizi Lanjut, Analisis Kebijakan Pangan dan Gizi Lanjut, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Wanita, dan Kesehatan Keluarga. Penulis dapat dihubungi melalui email: musafaah01@ulm.ac.id

PROFIL PENULIS



Purwati, S.ST., MPH. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan D3, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menekuni bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Sekarang ini mengajar bayi, balita dan anak pra sekolah, asuhan kebidanan nifas dan menyusui dan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Selain mengajar penulis juga menekuni bidang penelitian dan pengabdian sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi serta menjadi pembicara seminar. Saat ini penulis merupakan Kepala Program Studi Kebidanan D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto masa jabatan 2024/2027. Buku ini merupakan karya kelima penulis, harapan penulis semoga buku ini bermanfaat sebagai bahan belajar bagi mahasiswa kebidanan.

SINOPSIS BUKU

Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai peran Program Keluarga Berencana (KB) dalam pencegahan stunting, dengan fokus pada pentingnya perencanaan keluarga yang baik sebelum konsepsi. Stunting, yang menjadi masalah kesehatan global dan nasional, terutama di Indonesia, diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan gizi dan praktik pengasuhan yang tidak tepat. Dalam konteks ini, buku ini menekankan bahwa perencanaan keluarga yang efektif dapat mengurangi risiko stunting dengan memastikan jarak kelahiran yang sehat dan mempersiapkan calon ibu secara fisik dan mental.

Isi Buku

1. **Pengantar Stunting:** Buku ini dimulai dengan penjelasan tentang stunting, dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta statistik terkini mengenai prevalensinya di Indonesia. Penulis menggambarkan bagaimana stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi tetapi juga oleh faktor sosial dan ekonomi.
2. **Peran Keluarga Berencana:** Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi bagaimana program KB berkontribusi dalam mencegah stunting melalui pengaturan jarak kelahiran, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan. Penulis menyoroti pentingnya mendidik masyarakat tentang manfaat KB untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
3. **Strategi Implementasi:** Buku ini menawarkan strategi praktis untuk implementasi program KB yang efektif dan bagaimana kebijakan KB di Indonesia, termasuk penyuluhan kepada calon pengantin dan masyarakat umum mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Penulis juga membahas kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung program KB.

Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai peran Program Keluarga Berencana (KB) dalam pencegahan stunting, dengan fokus pada pentingnya perencanaan keluarga yang baik sebelum konsepsi. Stunting, yang menjadi masalah kesehatan global dan nasional, terutama di Indonesia, diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan gizi dan praktik pengasuhan yang tidak tepat.

Dalam konteks ini, buku ini menekankan bahwa perencanaan keluarga yang efektif dapat mengurangi risiko stunting dengan memastikan jarak kelahiran yang sehat dan mempersiapkan calon ibu secara fisik dan mental.

Isi Buku

1. Pengantar Stunting: Buku ini dimulai dengan penjelasan tentang stunting, dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta statistik terkini mengenai prevalensinya di Indonesia. Penulis menggambarkan bagaimana stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi tetapi juga oleh faktor sosial dan ekonomi.

2. Peran Keluarga Berencana: Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi bagaimana program KB berkontribusi dalam mencegah stunting melalui pengaturan jarak kelahiran, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan. Penulis menyoroti pentingnya mendidik masyarakat tentang manfaat KB untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

3. Strategi Implementasi: Buku ini menawarkan strategi praktis untuk implementasi program KB yang efektif dan bagaimana kebijakan KB di Indonesia, termasuk penyuluhan kepada calon pengantin dan masyarakat umum mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Penulis juga membahas kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung program KB.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-30-6



9

786347

139306